



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL



Serie: Documentos Técnico Normativos

La Paz - Bolivia
2021



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL



Serie: Documentos Técnico Normativos

**La Paz - Bolivia
2021**

R-BO
W26.5
M665g
No.499
2021

Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Planificación. Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE)
Guía Operativa de Aplicación del Comité de Análisis de la Información para establecimientos de primer, segundo nivel de atención y nivel municipal. Ministerio de Salud y Deportes; Rocco Alan Walter Abruzzese Castellón. Coaut. 2ed. La Paz : Mira Impacto Gráfico, 2021

70p.: ilus. (Serie: Documentos Técnico-Normativos No. 499)

Depósito legal: 4-1-458-2021 P.O.

- I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD
- II. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD
- III. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD
- IV. DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN EN SALUD
- V. POLÍTICAS, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD
- VI. PROGRAMACIÓN DE POLÍTICAS
- VII. GUÍA
- VIII. BOLIVIA
1. t.
2. Serie
3. Abruzzese Castellón, Rocco Alan Walter. Coaut.

GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL

Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) Calle Fernando Guachalla, No 342, Zona Sopocachi, Edificio Víctor Piso 3 Teléfono-Fax(02) 2440590 - 2440336
<https://www.minsalud.gob.bo> <http://snis.minsalud.gob.bo/publicaciones>

Resolución Ministerial N° 528

Depósito Legal: N° 4-1-458-2021 P.O.

Elaboración:

Dr. Rocco Abruzzese Castellón – COORDINADOR NACIONAL SNIS-VE

Edición:

Tec. Pedro Pablo Vásquez Choque – Responsable Área Técnica-Estadística del SNIS-VE/MSyD

Dra. Helen Castillo Laura - Profesional Técnico Médico del SNIS-VE/MSyD

Revisión Área Técnica - Médica SNIS-VE/MSyD:

Dra. M. Ángela Vera Callisaya, RESP. VE. EN. TRANSM..

Dra. Gilda Fernandez Morillas, RESP. DETERMINANTES SOC.

Dra. Susana Solano Romero RESP. ESTRUCT. Y DEM.

Dra. Maritza Troche Quisbert, RESP. PROD. II, III NIVEL

Dra. Claudia Bernal Parra, RESP. VE. E.TRANSM.

Dra. Jhóvana Huanca Quispe, RESP. HECHOS VITALES

Dr. Braulio Velasquez Laura, RESP ANALISIS EST.

Comité Técnico de Publicaciones/DGPPS/MSyD

Comité de Identidad Institucional y Publicaciones/DGPPS/MSyD

Dr. Alvaro Terrazas Peláez

Dr. Juan Marcos Rodríguez Morales

Dra. Miriam Nogales Rodríguez

Dra. Diana Noya Pérez

Dr. Dante David Ergueta Jiménez

Dra. María del Carmen Del Carpio

Dra. Sdenka Maury Fernández

Dra. Tania Huanca Uluri

Sr. Rodrigo Omar Chipana Cortez

Sr. Marcelo Martínez Quisbert

La Paz, Sistema Nacional de Información en Salud/Vigilancia Epidemiológica – Dirección General de Planificación – Comité de Identidad Institucional y Publicaciones – Viceministerio de Gestión del Sistema Sanitario - Ministerio de Salud y Deportes 2021.

© Ministerio de Salud y Deportes 2021

Este documento es propiedad del Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, se autoriza su reproducción total o parcial, siempre que no sea con fines de lucro, a condición de citar la fuente y la propiedad.

Segunda Edición en Bolivia

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

AUTORIDADES NACIONALES

Dr. Jeyson Marcos Auza Pinto
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES

Lic. María Renee Castro Cusicanqui
**VICEMINISTRA DE PROMOCIÓN VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA Y MEDICINA TRADICIONAL**

Dra. Alejandra Hidalgo Ugarte
**VICEMINISTRA DE SEGUROS DE SALUD
Y GESTIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD**

Dr. Alvaro Terrazas Peláez
**VICEMINISTRO DE GESTIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO**

Cielo Jazmín Veizaga Arteaga
VICEMINISTRA DE DEPORTES

Dr. German Alejandro Crespo Infantes
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Dr. Rocco Abruzzese Castellón
COORDINADOR NACIONAL DEL SNIS-VE

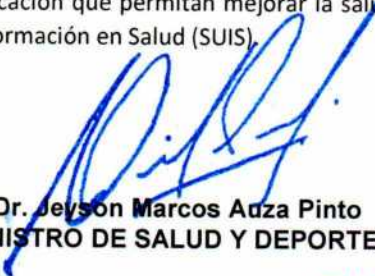
PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud y Deportes, se enmarca en la Agenda Patriótica 2025, como resultado del Proceso de Cambio, a partir del cual, el pueblo junto a sus organizaciones sociales implementan los 13 pilares clave para el VIVIR BIEN de todos y todas las bolivianas. A este efecto, cada una de las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia tienen que brindar su trabajo y esfuerzo en la creación de una nueva sociedad y Estado incluyente y participativo.

Los Planes Sectoriales de Desarrollo del Sector Salud siguen el mandato político y social de “Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, la construcción del Sistema Único de Salud en el marco de la política sanitaria de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), erradicando la pobreza e inequidad para VIVIR BIEN”. El mandato del Ministerio de Salud y Deportes es mejorar la salud de la población del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la Ley Nº 1152 hacia un Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, para ello se requieren instrumentos técnico normativos, que faciliten el cumplimiento de los planes de corto, mediano y largo plazo.

La interculturalidad, intersectorialidad, integralidad y participación social, se constituyen en los pilares del Modelo de Gestión de la Política Sanitaria, sobre la que la información debe fortalecerse para el análisis y toma de decisiones que incidan de manera efectiva sobre los determinantes de la salud. Los espacios de análisis y discusión de la información en salud se constituyen en uno de los principales aspectos que permiten contribuir a la toma de decisiones, con amplia participación de autoridades, personal de salud y comunidad, de cuya intervención en los problemas y las soluciones planteadas desemboquen en la elaboración del Plan Municipal en Salud, su ejecución y seguimiento. En este marco, el contar con una metodología operativa que coadyuve al desarrollo efectivo de las fases de preparación, desarrollo y seguimiento del “Comité de Análisis de Información” se constituye en un aspecto fundamental para el mejoramiento de la salud en los niveles operativos.

En la oportunidad el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), presenta la “Guía Operativa de Aplicación del Comité de Análisis de Información” que coadyuvará de manera más efectiva y eficiente al desarrollo y desempeño de los Comités de Análisis de Información en los niveles operativos del Sistema de Salud y su articulación con la estructura social en salud, en la identificación de problemas y planificación que permitan mejorar la salud de la población boliviana en el marco del Sistema Único de Información en Salud (SUIS).



Dr. Jeyson Marcos Auza Pinto
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES

Dr. Jeyson Marcos Auza Pinto
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES
Estado Plurinacional de Bolivia



Resolución Ministerial

15 DIC 2021

Nº 0528

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, determina que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, la Resolución Ministerial Nº 145 de 10 de marzo de 2005, crea el Comité de Identidad Institucional y Publicaciones del Ministerio de Salud, actual Ministerio de Salud y Deportes, como instancia de valoración de las estrategias y acciones relacionadas con la identidad institucional y control de calidad de las publicaciones.

Que, los Parágrafos I y II del Artículo 48 del Reglamento del Comité de Identidad Institucional y Publicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0871 de 7 de diciembre de 2018, señalan que una vez aprobada la publicación, la unidad proponente entrega al CIIP, la versión final del documento en formato impreso y digital; y que el Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la emisión de la Resolución Ministerial, adjuntando documentos; entre ellos el Acta de Aprobación del Documento e informes de revisión.

Que, el Numeral 22 del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero del 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo, establece como atribución de las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, emitir las resoluciones ministeriales.

Que, los incisos c) y d) de la Disposición Final Primera del Decreto Supremo Nº 4393 de 13 de noviembre de 2020, determinan que se adecua en toda la normativa vigente, la denominación "Ministerio de Salud", por "Ministerio de Salud y Deportes", y "Ministra (o) de Salud" por "Ministra (o) de Salud y Deportes".

Que, el Acta de Comité de Identidad Institucional y Publicaciones de 25 de noviembre de 2021, resuelve aprobar la "Guía Operativa de Aplicación del Comité de Análisis de la Información para Establecimientos de Primer, Segundo Nivel de Atención y Nivel Municipal", asignándola dentro de la serie de documentos Técnico Normativos con el número 499 para que continúe con el trámite para la emisión de la Resolución Ministerial.

Que, mediante Informe Interno MSyD/DGP/SNIS-VE/II/89/2021 de 1 de diciembre de 2021, emitido por el Coordinador Nacional SNIS VE, manifiesta que la "Guía Operativa de Aplicación del Comité de Análisis de Información para Establecimientos de Primer, Segundo Nivel de Atención y Nivel Municipal", contiene una metodología con pasos esquemáticos para el cumplimiento de las fases de preparación, desarrollo y seguimiento del CAI, con instrumentos digitalizados que ayudará a reducir los tiempos y optimizar recursos para una adecuada gestión municipal en salud, concluyendo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emita la Resolución Ministerial, aprobando la segunda edición de la citada Guía, para su posterior publicación y aplicación a nivel nacional.

Que, el Informe Legal MSyD/DGAJ/UAJ/II/1853/2021 de 10 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluye procedente la aprobación mediante Resolución Ministerial de la "GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL", en conformidad al contenido y sustento del Informe Interno MSyD/DGP/SNIS-VE/II/89/2021 de 1 de diciembre de 2021.

POR TANTO:

EL MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado.





RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la “GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL”, conforme al texto adjunto que forma parte integrante e indisoluble de la presente Resolución Ministerial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección General de Planificación, a través del Sistema Nacional de información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y archívese.




Mr. Heber Luis Lamas Cuatrecasas
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES


Legson Mares / Juan Pinto
MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES
Estado Plurinacional de Bolivia

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica SNIS-VE, se constituye en la instancia nacional encargada de desarrollar la gestión técnica y administrativa del manejo de la información en salud, su difusión y diseminación, como única fuente oficial promoviendo su uso y análisis para la toma de decisiones en el marco de la normativa funcional del ciclo y flujo de la información.

Es una necesidad imprescindible contar con información que permita la identificación de problemas y factores relevantes que afectan a la salud de la población boliviana, incluida la identificación de las determinantes, que coadyuven a la salud pública e instancias de decisión, en la determinación de las condiciones del estado de salud y toma de decisión.

Esta Guía busca mejorar la realización de los Comités de Análisis de Información (CAI), en establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, con alcance al nivel Municipal, con participación del personal de salud, autoridades municipales, autoridades locales de salud y población en general.

Pretende facilitar la realización del CAI, mejorar la comprensión de problemas y causas, para tomar decisiones más adecuadas, facilitar la articulación del análisis del CAI con la planificación a corto plazo, (Plan Operativo Anual POA) referidos a las acciones en salud y a la planificación a mediano plazo (Plan Municipal de Salud).

Esta Guía operativa contiene una metodología con pasos esquemáticos para el cumplimiento de las fases de preparación, desarrollo y seguimiento del CAI, con instrumentos digitalizados que ayudarán a reducir los tiempos y optimizar recursos para una adecuada gestión municipal en salud.

El documento presenta en su primera parte antecedentes, conceptos y consideraciones generales del CAI, seguidamente presentan la relación de los procesos de planificación del CAI y su vinculación con la estructura social en salud. A continuación, expresa los procesos operativos de las fases de preparación, desarrollo y seguimiento del comité de análisis de información.

GLOSARIO

CPN: Control Prenatal

CAI: Comité de Análisis de Información

E.S.: Establecimientos de Salud

ESS Estructura Social de Salud

FORSA: Proyecto Fortalecimiento de Redes de Salud Materno Infantil

GAM: Gobierno Autónomo Municipal

JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón

MS: Ministerio de Salud

MPCS: Matriz de Problemas Causas y Soluciones

NAC: Normas de Atención Clínica

PDES: Plan de Desarrollo Económico Social

PSDI: Plan Sectorial de Desarrollo Integral

POA: Plan Operativo Anual

PTDI: Plan Territorial Desarrollo Integral

PMS: Plan Municipal de Salud

SNIS-VE: Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica

SAFCI: Salud Familiar Comunitaria Intercultural

SUS: Sistema Único de Salud

SUIS: Sistema Único de Información en Salud

SLIM: Servicios Legales Integrales Municipales

SRP: Sarampión, Rubeola y Parotiditis

SEDES: Servicio Departamental de Salud

CONTENIDO

1. ¿QUÉ ES EL CAI?	17
2. MARCO LEGAL	17
3. COMITE DE ANALISIS DE INFORMACIÓN (CAI)	18
4. OBJETIVO DE LA GUIA OPERATIVA DE CAI	19
5. ANTES DE ORGANIZAR UN CAI (REFLEXIONAR)	20
6. RESULTADOS DEL CAI	21
7. CONSIDERACIONES A LA APLICACIÓN DEL CAI	22
7.1 PERIODICIDAD Y PARTICIPANTES DEL CAI	22
7.2 LA PERIODICIDAD SEGÚN EL CICLO DE GESTIÓN DE DEMING	23
7.3 RELACIÓN DEL CAI CON LOS ESPACIOS DE DELIBERACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD	25
7.3.1 Relación con la planificación de la comunidad o barrio	26
7.3.2 Relación con la planificación del Gobierno municipal	26
7.3.3 Mesas municipales	26
7.4 BENEFICIOS SEGÚN NIVELES DE CAI	26
8. RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN	28
9. TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL CAI	28
10. METODOLOGÍA DEL CAI OPERATIVO: LAS TRES FASES	29
10.1 FASE DE PREPARACIÓN	30
10.1.1 Descripción de la fase de preparación.....	31
10.1.2 Formas de presentación de la información.....	33
10.2 FASE DE DESARROLLO	35
10.2.1 Descripción de los pasos de la fase de desarrollo	38
10.2.2 Para mejorar el análisis técnico se deben realizar los siguientes pasos en la presentación	40
10.3 FASE DE SEGUIMIENTO	47

11. EVALUACIÓN DEL CAI	52
11.1 RESUMEN CICLO PARA MEJORAR EL MANEJO DEL CAI, UTILIZANDO LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE CONTROL.	54
11.2 BENEFICIOS DE FORTALECER EL CAI	55
12. EPÍLOGO	55
13. BIBLIOGRAFÍA	56
14. ANEXOS	57

1. ¿QUÉ ES EL CAI?

Es un espacio de discusión, análisis de información e intercambio de opiniones sobre problemas relacionados con la situación de salud, sus determinantes y factores de riesgo de una población determinada. Sirve para la toma de acciones y soluciones a corto plazo y está vinculada a la planificación de mediano plazo, con la participación de actores clave del Gobierno Autónomo Municipal, de la Estructura Social en Salud y del Personal de Salud.

2. MARCO LEGAL

La Constitución Política del Estado en su artículo 35, refiere que el Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

En su artículo 37 menciona también la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, constituyéndose en una función suprema y primera responsabilidad financiera, por lo cual deberá priorizarse la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

El Decreto Supremo N°. 4257 del 04 de junio de 2020 a objeto modificar el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, en su capítulo XVI establece la nueva estructura jerárquica del Ministerio de Salud:

1. Ministra(o) de Salud,
2. Viceministerio de Gestión del Sistema Sanitario,
3. Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional e Interculturalidad,
4. Viceministerio de Seguros de Salud.

Las principales atribuciones de la Ministra(o) de Salud, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, en el marco de sistemas de información son las siguientes:

- A. Formular, regular y fiscalizar políticas públicas en salud.
- B. Ejercer la rectoría, regulación y conducción sanitaria sobre todo el sistema de salud.
- C. Regular, planificar, controlar y conducir el Sistema de Salud, conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo, público, privados y sin fines de lucro, así como la medicina tradicional.
- D. Vigilar el cumplimiento y primacía de las normas relativas a la salud pública.

La Ley N°. 14100 de 05 de noviembre de 1976, crea el Sistema Nacional de Información Estadística SNIE, del cual forma parte el *Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia*

Epidemiológica SNIS-VE, dicha ley confiere al SNIE, autoridad normativa sobre todos los sistemas de información estadística del sector.

La Resolución Ministerial N°. 1022 de 6 de diciembre de 1990, establece la creación del Sistema Nacional de Información en Salud con la denominación de Subsistema Nacional de Información, estableciendo sus instrumentos y la organización del Comité de Análisis de Información (CAI).

La Resolución Ministerial N°. 2010 de 20 de diciembre de 2013 en su Art. quinto establece el cumplimiento riguroso del ciclo de la información que permita fortalecer el Comité de Análisis de la Información (CAI) donde se genera la información, con el fin de promover el uso de la misma.

La Resolución Ministerial N°. 294 del 10 de abril de 2015 aprueba la publicación, difusión e implementación en el Sistema Nacional de Salud de los documentos técnicos normativos "Guía de Procedimientos de la Gestión Participativa Local en Salud", "Guía de Procedimientos de la Gestión Participativa Municipal en Salud".

La Ley 1152, del 20 de febrero del 2019, que viabiliza la implementación del Sistema Único de Salud SUS, que en su Capítulo VI, establece la puesta en marcha del SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN EN SALUD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, que indica que todos los centros deben centralizar su información en el Ministerio de Salud y todos ellos están obligados a utilizar la información en formato digital.

La Resolución Ministerial N°. 1834 del 03 de diciembre de 2003 aprueba la implementación y aplicación del documento "GUÍA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (CAI)".

La Resolución Ministerial N°. 0046 del 30 de enero de 2020 autoriza la impresión, publicación, difusión e implementación en el Sistema Nacional de Salud de la "GUÍA OPERATIVA DE APLICACIÓN DEL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL MUNICIPAL".

3. EL COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (CAI)

El CAI es una metodología desarrollada a manera de una reunión de trabajo, con el fin de analizar indicadores epidemiológicos, de producción de servicios, estructura, determinantes, de gestión y financieros con información generada del *Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE)* y otras fuentes de información. Estos indicadores deben estar relacionados con la situación de salud de acuerdo al contexto, permitiendo identificar problemas de salud, establecer líneas de acción a corto plazo y planes de acción a mediano plazo, haciendo de la toma de decisiones un proceso participativo.

El **componente de gestión** de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) promueve la participación de la población organizada en los procesos de mejora de la salud, articulando actividades entre la comunidad, el establecimiento de salud y el municipio.



Las funciones de este componente, están dirigidas a planificar, ejecutar, realizar seguimiento e impulsar la elaboración del *Plan Municipal de Salud*, así como su ejecución a través del POA municipal.

El CAI, a partir del análisis de la información en salud de diferentes periodos, busca soluciones a corto plazo, se constituye en la base para la planificación a mediano plazo, este espacio también debe servir como una herramienta para una nueva planificación a largo plazo.

Se han desarrollado varias experiencias para mejorar la atención de la salud, es imprescindible mejorar la capacidad de gestión en salud a través de los *Comités de Análisis de la Información CAI*, donde el personal de salud, autoridades municipales y autoridades de las comunidades o barrios, tienen la misión de tomar decisiones en favor de la salud de la población.



A partir del ciclo de Gestión de Deming (¹) se propuso mejorar la **Planificación – Ejecución – Verificación - Acción [retroalimentación] del CAI**, con una lista de acciones para asegurar el cumplimiento de las fases del CAI, de esta manera a través del plan de acción se pretende vincular:

- ① Con la planificación de la comunidad o barrio, descrito en la gestión local del componente de Gestión de la política SAFCI.
- ② Con la planificación a corto plazo, la programación operativa anual (POA) municipal, generando estrategias para el cumplimiento a las metas del sector salud.
- ③ Con la planificación a mediano plazo, el plan municipal en salud y luego al plan territorial desarrollo Integral del municipio (PTDI).

Del análisis del comportamiento de la implementación del CAI, esta guía propone su simplificación y ejecución mediante una metodología ágil y sencilla, que permita la adecuada comprensión y manejo de indicadores, mayor participación y mejora de la toma de decisiones.

4. OBJETIVO DE LA GUÍA OPERATIVA DEL CAI

Facilitar la realización del CAI a nivel local a través de una metodología operativa de apoyo al personal de salud, autoridades municipales y autoridades de la comunidad, para comprender la situación de salud y para tomar decisiones plasmadas en acciones inmediatas a corto plazo, vinculadas con la planificación a mediano plazo que benefician a la persona, familia y población en cuanto a la atención en salud, reducción de los riesgos en salud, prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables y recuperación de la salud en el marco de la política SAFCI.

¹ También conocido como *ciclo PDCA* (de la traducción oficial al español **Planificar-Hacer-Verificar-Actuar**) o *espiral de mejora continua*, es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad en cuatro pasos.

5. ANTES DE ORGANIZAR UN CAI (REFLEXIONAR)

Si usted es responsable de realizar el CAI debería responder estas preguntas:

1. ¿Conoce una metodología eficiente y eficaz para aplicar el CAI?
2. ¿El personal de salud promueve la realización del CAI?
3. ¿Cumple las tres (3) fases del CAI?
4. ¿Cumple con la periodicidad establecida en la Guía del CAI?
5. ¿Elabora e implementa el Plan de Acción?
6. ¿Qué resultados significativos ha tenido a partir del Plan de Acción del CAI?
7. ¿Conoce la diferencia entre un CAI de 1er nivel y 2do nivel y un CAI de nivel Municipal?

Si las respuestas a las anteriores preguntas han sido negativas, es muy posible que tengamos algunas de las siguientes justificaciones:

1. No hay presupuesto.
2. No tengo tiempo.
3. No he recibido capacitación.
4. Las autoridades no pueden, ni tienen tiempo para participar.
5. Sabemos que es necesario el CAI, pero no sé cómo hacerlo.
6. El CAI no cuenta con recursos para garantizar la participación de la Estructura Social en Salud.

Justificaciones comunes cuando se organizan CAI, en sus tres fases.

PREPARACIÓN	DESARROLLO	SEGUIMIENTO
		
No hay presupuesto	La autoridades fueron convocadas pero no asistieron	No hay tiempo para hacer seguimiento
Tengo otras actividades, no tengo tiempo	Terminemos rápido el CAI, tenemos actividad deportiva	Que seguimiento realizaré, si no vinieron las autoridades
No conozco la guía, SEDES no me ha capacitado	Tenemos media hora para el plan de acción	El Plan de acción no tiene tiempos, no hay como hacer seguimiento

ENTONCES...**¿CUÁNDO SE CONSIDERA UN CAI?**

Para ser considerado un CAI, debe cumplir los siguientes **6 Puntos clave**:

1. Preparación de la información, convocatoria y logística adecuada.
2. Participación de actores claves: autoridades de la Estructura Social en Salud, Gobiernos Autónomos Municipales (solo en caso de un CAI de nivel municipal) y Personal de Salud.
3. Presentaciones claras didácticas, que permitan la comprensión de todos los actores.
4. Elaboración del acta del CAI.
5. Elaboración de un plan de acción.
6. Seguimiento a los planes de acción.

6. RESULTADOS DEL CAI

Al finalizar el CAI, el producto principal es un **Plan de Acción** que debe tener soluciones a la problemática en salud de la población respecto a:

- A. Acciones técnicas para mejorar competencias del personal de salud; como capacitación y supervisión en la aplicación de las normas nacionales vigentes.
- B. Acciones vinculantes con la Planificación a corto plazo (POA Municipal), para mejorar el equipamiento, infraestructura, o realizar actividades de prevención y promoción en salud.
- C. Planificación a Mediano plazo (Plan municipal en salud - Plan territorial de desarrollo integral del municipio), abordaje de determinantes de la salud y oferta de servicios de atención.
- D. Acciones para promover mayor participación de la población en la búsqueda de soluciones, alianzas estratégicas y hábitos de vida.

7. CONSIDERACIONES A LA APLICACIÓN DEL CAI

7.1 PERIODICIDAD Y PARTICIPANTES DEL CAI

La periodicidad y participantes del CAI a nivel de municipio y de establecimientos de salud deben ser:

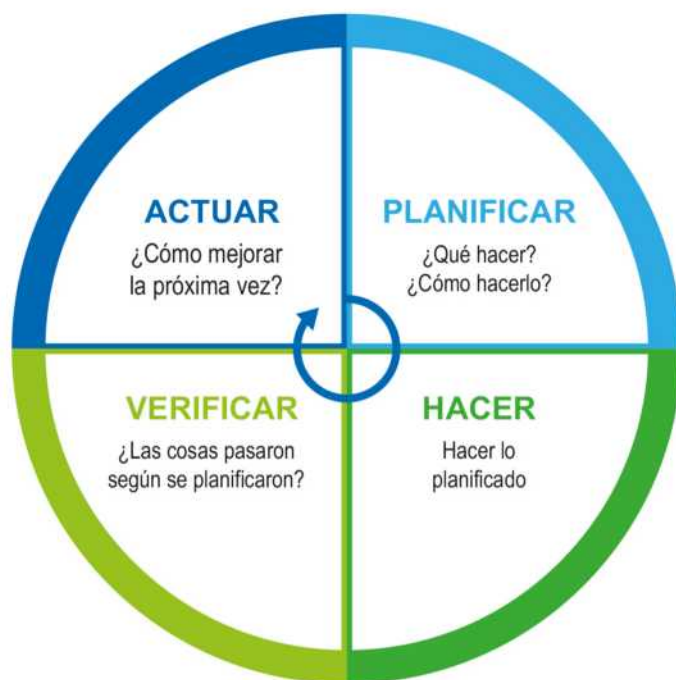
NIVEL DE CAI	PERIODICIDAD	PARTICIPANTES
CAI Municipal	4 veces al año (Trimestral) <i>Realizar el CAI al siguiente mes culminado el trimestre.</i>	- Alcalde y Responsable de Salud del Consejo Municipal - Coordinadores de Redes, Consejo Social Municipal de Salud (CSMS), personal de salud de los establecimientos, otros recursos humanos (especialistas SAFCI, médico Bono Juana Azurduy, prestadores de servicios de medicina tradicional y ancestral, personal de la UNI, programa "Mi Salud") - Estructura social del municipio u otras autoridades o líderes comunitarios o vecinales. Concejo Social Municipal de Salud (CSMS) - Otras instituciones relacionadas al sector salud.
CAI de Establecimiento de Primer nivel	4 veces al año (Trimestral) ² <i>Realizar el CAI al siguiente mes culminado</i>	Personal de salud: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, de todos los programas, otro recurso que trabaja directamente con el sector salud (prestadores de servicios de

² El CAI de Establecimiento de Salud (Guía del CAI-2014) establece su periodicidad mensual, sin embargo, no es cumplido habitualmente por la corta temporalidad para realizar acciones de solución, estableciéndose a partir de la emisión de la presente guía que los CAI deben ser realizados trimestralmente (Incluye Hospitales de 2do. Nivel).

	<i>el trimestre.</i>	medicina tradicional y ancestral). • Comité Local de salud (CLS), Autoridades locales de salud (ALS). • Agentes comunitarios de salud (ACS) • Otras autoridades, líderes comunitarios o vecinales, instituciones relacionadas al sector salud.
CAI de Establecimiento de Segundo nivel.	4 veces al año (Trimestral) <i>Realizar el CAI al siguiente mes culminado el trimestre.</i>	• Alcalde, o su representante, Responsable de Salud del Consejo Municipal. • Consejo Social Municipal de Salud (CSMS), • Coordinadores de Redes, Responsable Municipal en salud, personal de salud del establecimiento, otros recursos humanos en salud, médicos especialistas, responsables de servicio del Hospital • Estructura Social en Salud y otras instituciones relacionadas al sector salud.

7.2 LA PERIODICIDAD SEGÚN EL CICLO DE GESTIÓN DE DEMING

Un CAI bien desarrollado en una gestión anual debe seguir el siguiente ciclo de gestión de salud:



Los cuatro 4 comités de análisis de información en un periodo de un año calendario, deben permitir realizar el seguimiento a los siguientes procesos:

1. CAI de inicio de gestión (enero a diciembre de la anterior gestión)

Es el CAI de arranque en el que se evalúan las acciones que el sector salud realizó y las metas que cumplió en la gestión pasada durante el periodo de enero a diciembre. A partir de esta evaluación, se incorporan actividades para la presente gestión como ser capacitación – seguimiento - supervisión para el cumplimiento de las metas, equipamiento, mejoras en la infraestructura, también para el trabajo con la comunidad, para mejorar la oferta de servicios de salud y para el abordaje de las determinantes de la salud. Se recomienda efectuarlo durante el primer mes del año.

2. CAI de seguimiento Trimestral 2do. (enero a marzo), 3ro. (abril a junio) 4to. (julio a septiembre)

Debe servir para verificar el avance de la planificación anual a corto plazo, mejorar la ejecución de recursos económicos (POA municipal), mejorar el seguimiento a la atención de la población en los diferentes programas de salud e identificar factores que dificultan su cumplimiento en todos los establecimientos de salud. Se recomienda efectuarlo al siguiente mes de concluir el trimestre Ej.: el de enero a marzo, realizarlo en el mes abril, de la misma forma los siguientes CAI. El CAI de 4to. Trimestre debe ser realizado en el mes de enero de la siguiente gestión.

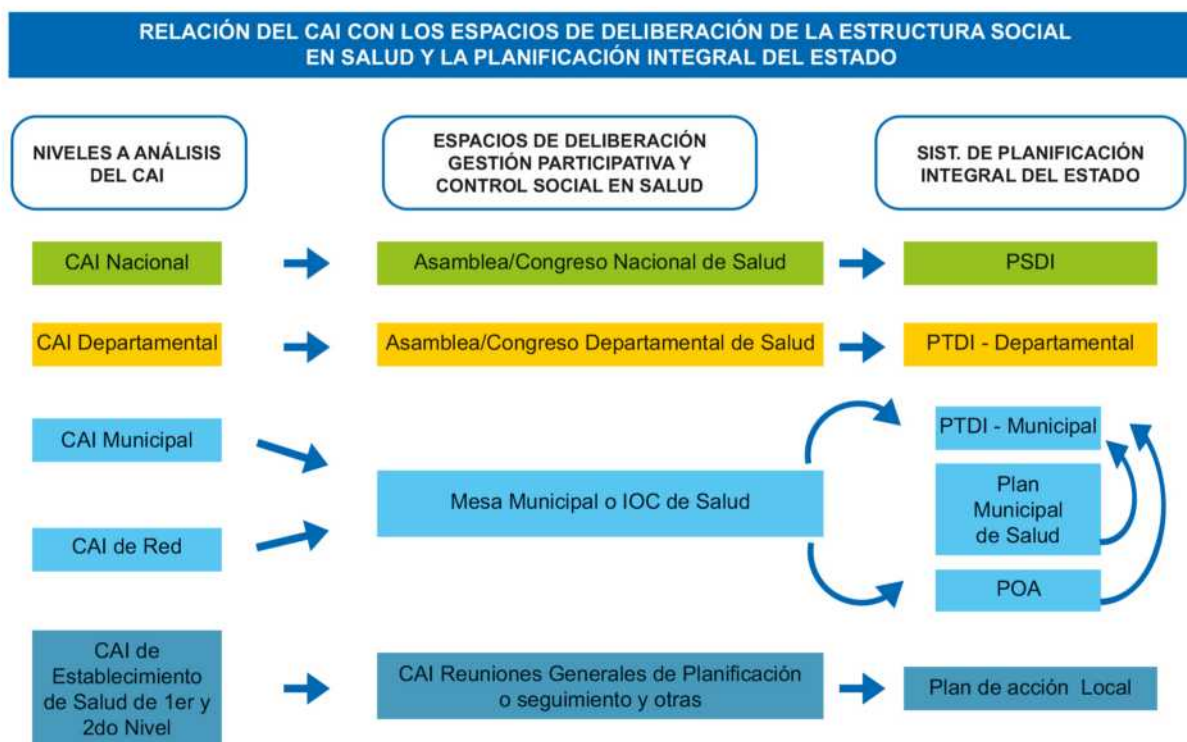
3. CAI de preparación y seguimiento al Plan Municipal en salud

Realizar el CAI, con información comparativa de cinco gestiones, servirá como insumo de diagnóstico para la elaboración de la planificación a mediano plazo, se constituye en un proceso de preparación y análisis de la información previa a la elaboración de un plan municipal de salud que debe ser efectuado cada cinco años de acuerdo a la gestión municipal, es el plan municipal de salud que debe ser incorporado en el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).

Realizar un CAI comparativo de cinco años, servirá como insumo de diagnóstico para la elaboración de planes estratégicos institucionales de establecimientos de salud de primer y segundo nivel.

El CAI comparativo de cinco años (si el municipio cuenta con un plan quinquenal) servirá para dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores planeados en este período.

7.3 RELACIÓN DEL CAI CON LOS ESPACIOS DE DELIBERACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD



7.3.1 Relación con la Planificación de la Comunidad o Barrio. - En el análisis de los indicadores y plan de acción del CAI también se debe tomar en cuenta la planificación que se trabaja con la comunidad reflejado en **la matriz de problemas causas y soluciones** (MPCS) en la que se identifican: la demanda de oferta de atención del establecimiento de salud, determinantes de la salud, factores ambientales y estilos de vida.

7.3.2 Relación con la Planificación del Gobierno Autónomo Municipal. - El plan de acción del CAI puede identificar necesidades de proyectos, incorporar los proyectos de las comunidades y las necesidades del establecimiento en salud de forma participativa en el Plan Municipal de Salud y luego al Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio (PTDI).

7.3.3 Mesas Municipales. - El CAI se constituye en un insumo de análisis preparatorio para las mesas municipales y es la instancia donde las decisiones tomadas son aprobadas con presupuesto. La mesa municipal debe relacionar dos partidas importantes en la asignación de recursos económicos: las que están asignadas al sector salud y las externas al sector salud. La mesa municipal debe incluir recursos para la planificación a mediano plazo y también se debe definir los recursos a corto plazo de acuerdo a los procedimientos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

El CAI genera resultados que deben ser aprovechados en la gestión municipal en salud para evitar duplicar el trabajo con herramientas que puedan ser creadas para identificar problemas y proponer soluciones.

7.4 BENEFICIOS SEGÚN NIVELES DE CAI

De acuerdo a normativa vigente del CAI en cada nivel, deben participar los siguientes actores: el sector salud, los representantes de la comunidad o barrio de acuerdo a la gestión local en salud y las autoridades o representantes del Gobierno Autónomo Municipal.

NIVEL DE CAI	BENEFICIOS
CAI Municipal	1. Planificación y programación del POA anual. 2. Seguimiento a Ejecución del POA anual. 3. Seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas del sector de salud. 4. Insumo de diagnóstico para el Plan Municipal 5. Seguimiento al Plan Municipal. 6. Promueve la participación de la comunidad en las acciones de salud.
CAI Hospital de Segundo Nivel	1. Planificación y programación del POA para el establecimiento. 2. Seguimiento a la ejecución del POA programado para el establecimiento. 3. Diagnóstico para el plan institucional del Hospital. 4. Seguimiento al plan institucional del Hospital. 5. Seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas del sector de salud. 6. Promueve la participación de la comunidad en las acciones de salud.
CAI de Establecimiento de Salud Primer nivel.	1. Planificación y programación del POA para el establecimiento. 2. Seguimiento a la Ejecución del POA programado para el establecimiento. 3. Seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas del sector de salud. 4. Insumo de diagnóstico para el Plan Institucional. 5. Seguimiento al Plan Institucional. 6. Promueve la participación de la comunidad en las acciones de salud a través de la planificación y seguimiento de la matriz causa y soluciones junto a la comunidad

8. RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

En todos los espacios de gestión se debe analizar:

- 1) Demandas y necesidades de la población que son las determinantes de la salud, causas y factores de la Morbi-Mortalidad.
- 2) Cómo mejorar la oferta de la atención por parte de los establecimientos de salud. (recursos humanos en salud, equipamiento básico e infraestructura)

Toda esta demanda social y necesidades de atención deben reflejarse en la planificación del Gobierno Autónomo Municipal a través del Plan Municipal en Salud y luego en el Plan Territorial de Desarrollo Integral, todo esto reflejado en el Plan Operativo Anual del Municipio.

Por ello un buen POA debe comprender recursos relacionados con las necesidades reales del establecimiento de salud y de las comunidades.

9. TIEMPO DE DURACIÓN DE REALIZACIÓN DEL CAI

Para optimizar la toma de decisiones en el plan de acción, se debe tener en cuenta el tiempo de duración de la fase de desarrollo para garantizar la participación efectiva de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal, comunidad o barrio.

- 1) En el CAI Municipal, se deben presentar los indicadores prioritarios que tienen mayor dificultad o no hayan alcanzado metas óptimas. Esta presentación deberá ser resumida y en gráficos, expresando un consolidado de todos los establecimientos de salud del municipio, de lo contrario será muy largo para las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal, las comunidades y barrios. Esto dará lugar a que los asistentes no participen completamente y no realicen lo más importante que es el plan de acción.
- 2) En los establecimientos de salud se identifican los indicadores más relevantes que reflejen la situación de salud en forma completa.
- 3) En los establecimientos de salud y municipios lo recomendable es que la fase de desarrollo pueda realizarse tres (3) horas o una mañana, máximo en un día.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL CAI

Sala Situacional y monitoreo mensual

Tiempo limitado



Se puede escuchar una sola presentación de la situación de salud no a todos los Establecimientos de Salud... de esta forma las Autoridades se quedarán.

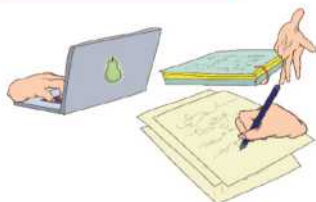
~~2~~
Días

Para las Autoridades incluyendo los representantes de la comunidad mostrar indicadores que sean problemas o hayan logrado las metas óptimas. Por ello seleccionar indicadores importantes y relevantes.

10. METODOLOGÍA DEL CAI OPERATIVO: LAS TRES FASES

3 Fases de la Metodología CAI

1. Fase de preparación



Contar con los datos organizados

Identificar y seleccionar indicadores integrales para CAI

Presentación clara y técnica en la CAI

2. Fase de desarrollo



Análisis y discusión entre todos el GAM, ES y PS

Elaboración del Plan de acción e identificación de recursos económico y técnico

3. Fase de seguimiento y mejoras



1. Soluciones técnicas de Capacitación, seguimiento, supervisión (Técnico)

2. Vinculación con el POA Ejecución, programación

3. Articulación con MESA Municipal (Elaboración, Ejec. Seguimiento del plan municipal)

4. Responsabilidad de Estructura Social y Población, Comunidad y Barrio

Toma de Decisiones débil

RM Resp. Municipal

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GAM y Estruct Social

PS Part Social y **EPV**

La siguiente, es una lista de acciones que ayudarán a comprender el proceso del CAI, y también servirán para evaluar una vez que éste haya finalizado.

10.1 FASE DE PREPARACIÓN

	FASE DE PREPARACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Conformar un equipo de conducción del CAI Municipal o Establecimiento de Salud (El equipo de conducción es el que dirige el CAI)	Acta de reunión
2	Cumplir la periodicidad del CAI establecida en el establecimiento de salud primer y segundo nivel y Municipal.	Verificar fecha según la frecuencia establecida
3	Preparar y seleccionar los indicadores de análisis de acuerdo a necesidad y priorización relacionado al plan municipal, PTDI o compromisos de gestión, por el ciclo del continuo de la vida (Atención, Prevención, Promoción, Referencia, Gestión u otros).	Matriz de Selección de Variables. (Digital)
4	Contar con información del presupuesto de salud, la programación y ejecución para la fecha en que se realice el CAI	Reportes de ejecución.
5	Preparar las presentaciones incorporando el análisis técnico de los indicadores no cumplidos y las causas identificadas.	Presentación PowerPoint.
6	Asegurar la participación de: • Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal. • Estructura Social en Salud (Consejo Social Municipal, Comité Local de Salud, Autoridades Locales en Salud) • Instituciones del Municipio (Educación, SLIM, Universidad, deporte) otras Se envió la convocatoria e invitación al Personal de Salud y autoridades del municipio con anticipación	Cartas de convocatoria y confirmación
7	Enviar con anticipación la agenda del evento, los temas e indicadores a ser presentados y analizados.	Agenda enviada

8	Preparar la logística anticipadamente. (Salón, ecran, equipo multimedia, suficientes sillas, iluminación y otros)	Observación del lugar
---	---	-----------------------

10.1.1 Descripción de la fase de preparación

1 Equipo de conducción del CAI; Es importante definir un equipo de trabajo para las tres fases del CAI, debe ser liderizado por el responsable municipal de salud, jefe médico o personal responsable del establecimiento de salud. El éxito del CAI es garantizar que todos los pasos sean cumplidos de manera eficiente para que la toma de decisiones sea efectiva.

2 Periodicidad del CAI



Establecer si se está cumpliendo la periodicidad y la frecuencia del CAI según el nivel que corresponda, en el establecimiento de salud de primer nivel y de segundo nivel trimestralmente como el Municipal.

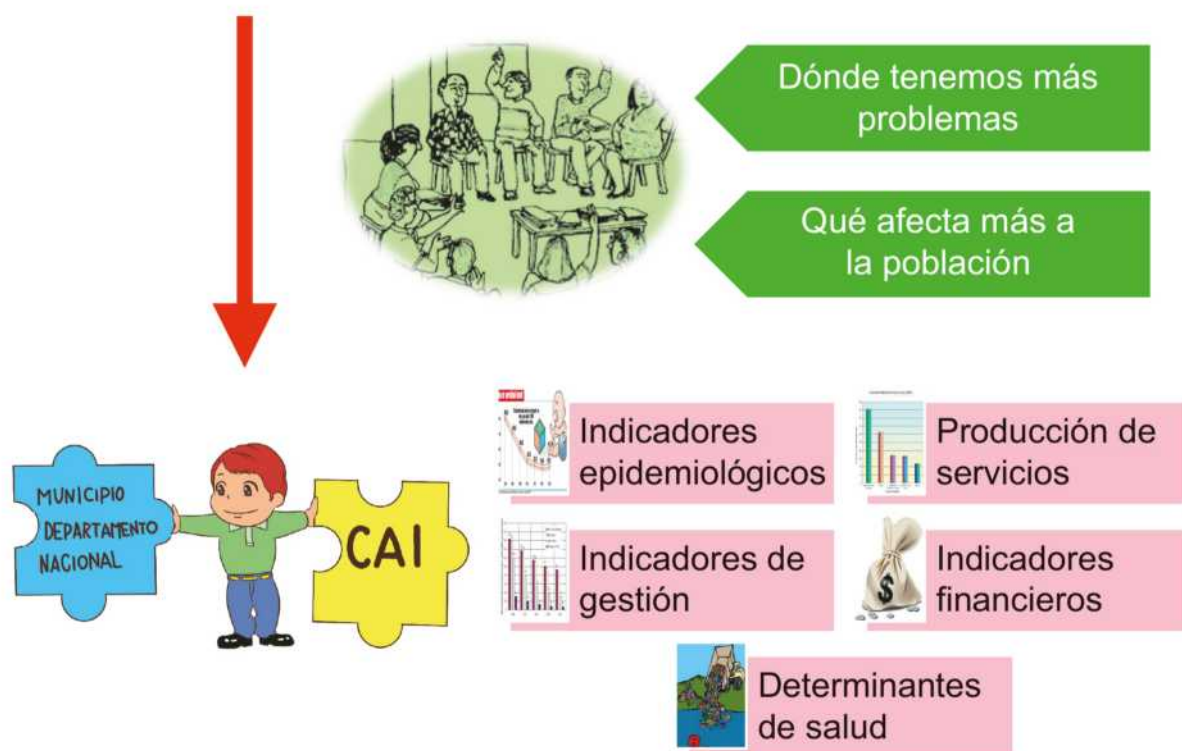
3 Preparar, seleccionar de los indicadores y temas de análisis:

- Primero seleccionar indicadores, por grupos del continuo de la vida y las funciones del sector salud como: Atención, Prevención, Promoción, Rehabilitación, Referencia, Gestión de acuerdo al perfil epidemiológico, morbimortalidad y otros.

- En el caso del CAI en los establecimientos de salud de 1er nivel y municipal tiene validez tomar en cuenta la población recabada de la Carpeta Familiar.
 - Es posible utilizar la información que se cuenta en la sala situacional.
 - También se deberán seleccionar los indicadores definidos en el Plan municipal, PTDI.
 - Seleccionar indicadores importantes de Estructura, Proceso y Resultados:
- 1) **ESTRUCTURA** Miden si se cuenta con infraestructura, equipamiento, materiales, insumos, medicamentos de acuerdo a normas vigentes del Ministerio de Salud y Deportes (por ejemplo, el número de centros equipados con salas de parto, transporte y medicamentos)
 - 2) **PROCESO** Miden la implementación de las Políticas de salud: Promoción, Prevención, Atención y Rehabilitación.
 - 3) **RESULTADO** Miden el impacto obtenido en la gestión y atención en prevención: por ejemplo; disminución de mortalidad infantil, cobertura de parto institucional.

ANÁLISIS DE INDICADORES

Selecciono los temas de análisis de acuerdo a necesidad y de plan municipal



Es importante que el Establecimiento de Salud o el Municipio cuenten con un sistema de monitoreo de los indicadores bien organizados y de esa información seleccionar aquellos de mayor importancia, relacionados a las necesidades de salud de la población, debemos preguntarnos: ¿Cuáles son los que demuestran mayores problemas de salud en la población?,

¿Cuáles son los de mayor interés para las políticas del municipio, departamento y Nacional?, debe ser establecido en reuniones previas con el equipo que prepara el CAI.



4 Contar con información del presupuesto de salud, programación y ejecución a la fecha de realización del CAI:

Es importante contar con la información presupuestaria para identificar si hay problemas de ejecución y/o programación de recurso necesarios para cumplir las acciones en salud.

5 Preparar las presentaciones incorporando el análisis técnico de los indicadores no cumplidos y las causas identificadas.

10.1.2 Formas de presentación de la información

A continuación, se ejemplifica una forma clara de mostrar la información:

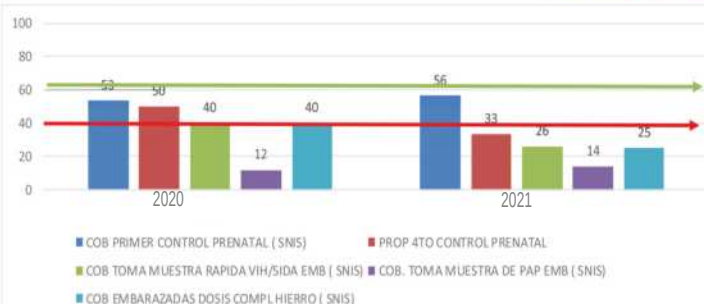
- En la parte superior se cuenta con un cuadro de números absolutos y se compara con la gestión pasada o con un mayor rango de años.
- En un recuadro colocar en el análisis técnico, un resumen de los problemas y los factores causales que pueden identificarse dentro de las siguientes seis categorías: Dificultades en RRHH en salud; falta de equipos médicos o deficiencia de infraestructura; dificultad en la meta programada; debilidad en los insumos o medicamentos; debilidad en acciones de promoción de salud y debilidad en la calidad de la información.
- En las gráficas donde existen barras comparativas entre 2 gestiones, marcar una línea verde que marca la meta a alcanzar y una roja para el avance hasta la fecha que se está midiendo.

EJEMPLO DE ANÁLISIS TÉCNICO

ATENCIÓN INTEGRAL CONTROL PRENATAL A LA MUJER EMBARAZADA

GESTIÓN 2020-2021

INDICADORES	2020	2021
EMBARAZOS ESPERADOS (Programación Pob. Asignada SNIS)	30	32
EMBARAZOS ESPERADOS (Programación Pob Carpeta Familiar)	24	25
NUMERO DE PRIMEROS CONTROLES PRENATALES	16	18
COB PRIMER CONTROL PRENATAL (SNIS)	53	56
NUMERO 4TO CONTROL PRENATAL	8	6
PROP 4TO CONTROL PRENATAL	50	33
NUMERO TOMA MUESTRA RAPIDA VIH/SIDA EMBARAZADAS	12	8
COB TOMA MUESTRA RAPIDA VIH/SIDA EMB (SNIS)	40	26
NUMERO TOMA MUESTRA DE PAP EMBARAZADAS	12	2
COB TOMA MUESTRA DE PAP EMB (SNIS)	12	14
EMBARAZADAS CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO	12	8
COB EMBARAZADAS DOSIS COMPL HIERRO (SNIS)	40	25



ANÁLISIS TÉCNICO:

Problema o Logro: No hay Integralidad por 4to control, Prueba de VIH, PAP, HIERRO, de acuerdo a la Población Asignada y real

Causas. RRHH: No capacitado en atención integral a la mujer

Equipos o Infraestructura: No se cumple con las normas en los establecimientos del área dispersa por no tener ambientes adecuados.

Medicamentos o Insumos: se tiene la tardanza en el retorno de los resultados de PAP, por el cual las usuarias pierden credibilidad.

Comunidad: Población fluctuante.

Promoción: No se esta haciendo seguimiento en la comunidad.

Calidad de la Información: No se registró los datos de PAP en el mes junio

Soluciones a corto Plazo

- Actualización y capacitación en la atención integral de la mujer, al personal nuevo y que reprobaron en la capacitación anterior.
- Puntualizar problemas encontrados en la atención integral de la mujer durante los concejos técnicos
- Gestionar con la GAM para poder implementar el IVAA en los establecimientos.

Otros puntos para tomar en cuenta en las presentaciones:

- En poblaciones pequeñas, el manejo de datos es pequeño, por ello es mejor mostrar números absolutos y no porcentajes.
- En otros casos es adecuado comparar la información de 5 años para verificar la tendencia del estado de salud, por lo menos para el primer CAI de la gestión anual.
- Para entender la situación actual se debe hacer una comparación de la situación local con la nacional y evidenciar qué tan lejos o tan cerca estamos de dicha situación nacional.
- Los gráficos de los indicadores no solo deben mostrar números o terminología técnica, para que sea comprensible a las autoridades comunitarias pueden utilizar gráficos o colores que representen riesgo (rojo), avance (amarillo), cumplimiento (verde)



Rango	Refrigeradores	Heladeras	Termos
Buenos	21	12	87
Regular	98	47	67
Malos	7		45



Rango	Ambulancia
Buenos	3
Regular	4
Malos	1



Rango	Radios
Buenos	13
Regular	20
Malos	19

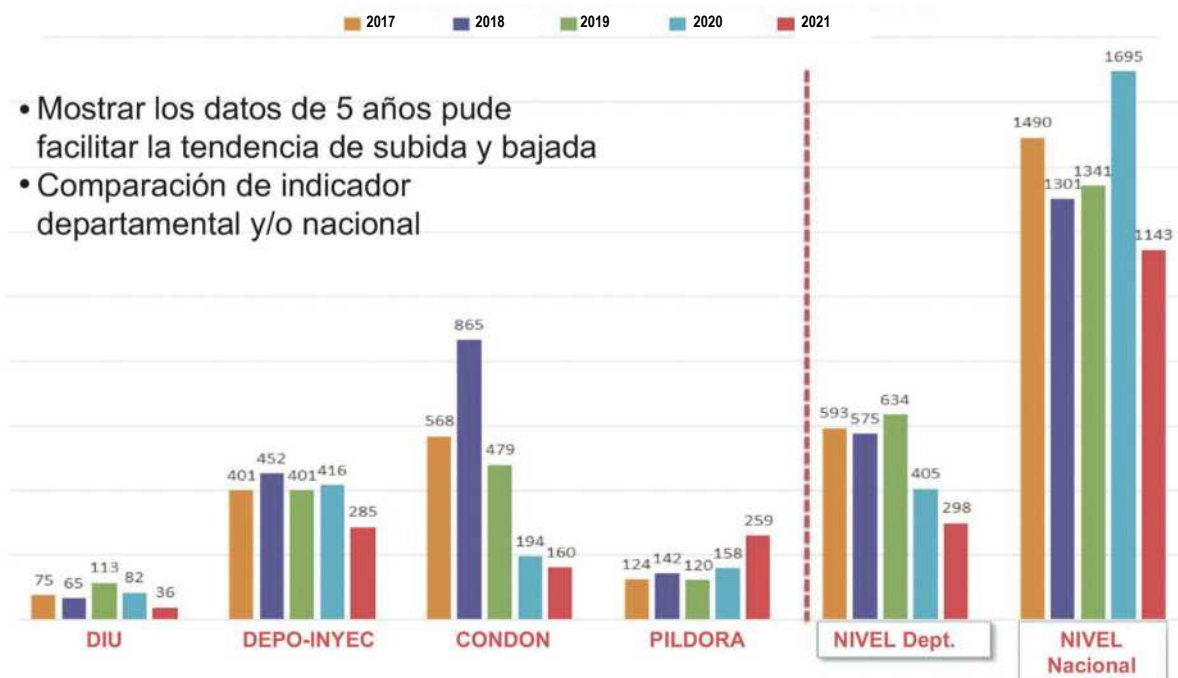


Rangos	Motos
Buenos	19
Regular	3
Malos	10



- El uso de dibujos en las diapositivas permite mejorar el entendimiento de los participantes, aunque se tenga debilidad en el nivel escolar, los participantes igual entenderán.
- Por ejemplo, dibujar una motocicleta, una ambulancia o una radio, permitirá comprender lo que se desea.
- Una imagen ayuda a entender mejor que una explicación.
- Use términos sencillos en lugar de terminología técnica.

EJEMPLO: PLANIFICACION FAMILIAR



- Mostrar los datos de 5 años puede facilitar la tendencia de subida y bajada
- Comparación de indicador departamental y/o nacional

- Mostrar datos comparativos de cinco años. Aunque los participantes no tengan conocimiento estadístico, esto permitirá que los mismos puedan diferenciar si las barras que muestran la información crecen o disminuyen en comparación a los 5 años pasados.
- Si es un CAI municipal, comparar con los niveles departamental y nacional. Esto permite medir cuál es la tendencia de la situación de salud de mi localidad comparada con el nivel nacional. Estas dos comparaciones son imprescindibles para entender la situación actual.

6 Asegurar y garantizar la participación de los actores claves: Enviar las invitaciones correspondientes y la convocatoria con anticipación oportuna a las:

- 1.- Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal.
- 2.- Autoridades de la Estructura Social en Salud.
- 3.- Personal de Salud.
- 4.- Instituciones: educación, defensoría, agricultura, deportes...otros.

7 Enviar con anticipación la agenda del evento y los temas e indicadores a ser presentados y analizados:

Es importante que los participantes conozcan sobre los temas o indicadores que se analizarán y los tiempos donde deben prepararse, esto para que en el momento de tomar decisiones ya muchas dudas estén aclaradas.

8 Preparar la logística anticipadamente: Salón, ecran, equipo multimedia, suficientes sillas, iluminación y otros. El lugar y el clima son determinantes ya que influirán en que los participantes estén atentos (lugares muy fríos o muy calientes harán que se distraigan). De igual manera, la ubicación de los participantes es importante para generar mayor análisis.

10.2 FASE DE DESARROLLO

Incluye las siguientes etapas:

- **Etapas informativas:** Presentación de los participantes, explicación de metodología de trabajo, lectura de acuerdos anteriores, presentación de resultados y recepción de los documentos.

- **Etapas de Análisis:** Se analizan los problemas de salud, indicadores de gestión, obstáculos para alcanzar los resultados, iniciativas o experiencias positivas de otros actores.
- **Etapas de identificación de alternativas de solución y toma de decisiones:** Se consideran los problemas, alternativas de solución, decisiones a tomar, acciones a realizar, tiempos y responsables.

Estas etapas se colocaron en actividades para verificar:

	FASE DE DESARROLLO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Confirmar la asistencia y realizar la presentación de los participantes: a) Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal en el CAI municipal (Alcalde, o Miembros del Concejo Municipal, u Oficial de Desarrollo Humano, Financiero, o Responsable de Salud del Concejo) b) Presidente del Concejo Social Municipal en Salud, Representantes del Comités Locales de Salud y/o representantes de la Comunidad. c) Personal de salud de los Establecimientos de Salud convocados. d) Otros representantes de instituciones	Acta
2	Participación de otros sectores o instituciones como Educación, Medio Ambiente, Producción, Defensorías, Cooperantes u otros.	Acta
3	Realizar la explicación de la agenda y de la metodología de trabajo a seguir durante el CAI.	Presentaciones
4	Realizar la lectura de compromisos y el seguimiento al plan de acción anterior con los compromisos de todos los actores	Acta

5	Presentar y realizar el análisis técnico de los indicadores priorizados. por grupos del ciclo Vital (Atención, Prevención, Promoción, Rehabilitación, Referencia Gestión u otros), identificando problemas, sus causas o el logro y sus fortalezas con gráficos fáciles de entender.	Presentaciones
6	Análisis de los riesgos de mortalidad en grupos vulnerables. Las causas fueron descritas de manera entendible.	Presentaciones
7	La presentación de los datos fue realizada sin errores y coherente al SNIS -VE. Calidad de información.	Presentaciones
8	Análisis de los problemas identificados sus causas. Las soluciones fueron reflejadas en un plan de acción consensuado de forma participativa.	Instrumento de plan de acción.
9	Tomar decisiones. Se asignó responsabilidades específicas a las autoridades, en el plan de acción A) Estructura Social, B) Gobierno Municipal y C) Personal de Salud. Y se realizó el Acta del CAI con sus firmas	Acta y Plan de Acción
10	Se optimizó el tiempo de duración del CAI. (Tiempo de presentación, análisis y elaboración de plan de acción menor a 6 horas)	Confirmar

10.2.1 Descripción de los pasos de la fase de desarrollo

Etapa Informativa

1 Confirmar la asistencia y presentación de los participantes tomadores de decisión:

- Es importante garantizar la presencia de los tres (3) actores a nivel de municipio, ya que cada uno tiene responsabilidades y competencias para ejecutar las soluciones.
- En el caso del Establecimiento de Salud de primer nivel: los participantes claves serán la estructura social (Comités Locales de salud y Autoridades locales de salud) y el personal de salud que trabaja en el E.S
- Con relación a Hospitales de segundo nivel: al ser un establecimiento de referencia deberían estar los tres (3) actores del nivel municipal o sus representantes por su importancia en la toma de decisiones.

2 Verificar la participación de otros sectores e instituciones como Educación, Medio Ambiente, Producción, Defensorías de la niñez, Servicios Legales Integrales Municipales, Cooperantes u otros que trabajan en el nivel correspondiente: Estos actores son importantes para que en el plan de acción se incorporen acciones conjuntas en el marco de la intersectorialidad.

3 Explicar de la agenda y metodología de trabajo a seguir durante el CAI. Éste servirá para que los participantes tengan información de lo que se hará, de esta forma medir los tiempos para su participación y las intervenciones pertinentes para la toma de decisiones.

4 Realizar la lectura de compromisos y avance del seguimiento al plan de acción anterior con los compromisos de todos los actores. Esto motivará a los participantes a recordar cuáles fueron los acuerdos, si se cumplieron o están en proceso.

5 Presentar los indicadores priorizados y análisis técnico. - Organizado por grupo de edad del continuo de la vida, reflejando de forma integral la Atención, Prevención, Promoción, Recuperación, Referencia, Gestión y otros indicadores importantes. Para la discusión en el plan de acción se debe identificar, con gráficos fáciles de entender, los problemas de salud y sus causas o el logro de sus metas, sus fortalezas y las posibles soluciones.



Uso de gráficos didácticos: Para conseguir el apoyo de una persona o una institución en cualquier aspecto, es importante convencerla, para conseguir este cometido es necesario explicar de forma comprensible cuáles son los problemas causas y la mejor forma de solución.

Si empleamos términos y gráficos complejos los cuales son desconocidos para nuestro público y queremos conseguir apoyo de ellos, lo único que lograremos es aburrirlos y provocarles una tranquila siesta.

Esta forma de actuar debe ser considerada en el CAI Municipal y en de Establecimiento de Salud, al cual asisten autoridades comunitarias y municipales en mayor cantidad a diferencia de los CAIs

4to Control prenatal Municipio Poopó (enero a septiembre 2021)

4to Control prenatal Municipio Poopó
enero a septiembre 2021



El 2020 solo 6 de cada 10 mujeres realizaron 4 controles prenatales



El 2021 8 de cada 10 mujeres realizaron 4 controles prenatales

No realizar
control prenatal a
partir de la semana 14
del embarazo



de Red o Departamental. Es decir, si se pretende que la comunidad y autoridades municipales contribuyan a la solución de problemas, primero deben comprender lo que tratamos de explicar. Esto no sucederá si el personal de salud presenta información solo en barras y cuadros numéricos y la explicación es realizada en términos técnicos-médicos. En este sentido, es muy cómodo hablar en porcentajes para el personal de salud,

pero puede ser más cómodo si para la comunidad se habla en casos de cada 10 personas. (Ej. Solo 6 de cada 10 mujeres realizan el 4to control prenatal en un determinado periodo); (solo 2 de cada 10 niños menores de 4 años acceden a la segunda dosis de SRP en un periodo).

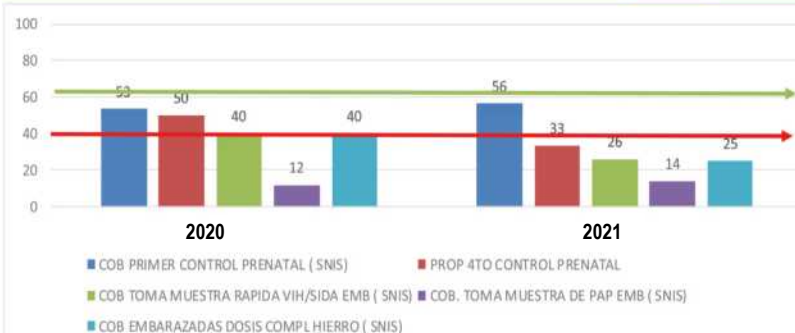
Es evidente que se debe lograr un equilibrio en las presentaciones y no exagerar en la simplicidad o en la complejidad. Lo más importante es considerar que con este método de informar se debe generar análisis y discusión profunda. “En ningún caso la simplicidad es sinónimo de superficialidad”, por tanto, considere la siguiente sugerencia:

10.2.2 Para mejorar el análisis técnico se deben realizar los siguientes pasos en la presentación:

1. Identificar los indicadores que reflejen la integralidad tanto positivos y negativos.
2. Establecer si cumple con la meta propuesta o si hay integralidad de acuerdo a los grupos del continuo de la vida.
3. Identificar cuáles indicadores son los más débiles.
4. Analizar 6 causas posibles y describir en el análisis técnico
 - ① Recurso humano en salud (falta o en acefalía o débil en el cumplimiento de la aplicación de protocolos o seguimiento)
 - ② La ausencia o deficiencia de infraestructura adecuada, equipamiento, transporte,
 - ③ La ausencia o deficiencia de Insumos o medicamentos,
 - ④ Población a ser atendida si la meta asignada es la real o existen problemas en el acceso geográfico a la población,
 - ⑤ Promoción de la salud, si existen determinantes de la salud como comportamientos, conductas y actitudes de la población que necesitaran intervención con procesos de gestión local y educación para la vida
 - ⑥ Calidad de la Información, si se identifica que los datos presentados tienen alguna información o no es la real.

EJEMPLO DE ANÁLISIS TÉCNICO ATENCIÓN INTEGRAL CONTROL PRENATAL A LA MUJER EMBARAZADA GESTIÓN 2020 -2021

INDICADORES	2020	2021
EMBARAZOS ESPERADOS (Programación Pob. Asignada SNIS)	30	32
EMBARAZOS ESPERADOS (Programación Pob. Carpeta Familiar)	24	25
NUMERO DE PRIMEROS CONTROLES PRENATALES	16	18
COB PRIMER CONTROL PRENATAL (SNIS)	53	56
NUMERO 4TO CONTROL PRENATAL	8	6
PROP 4TO CONTROL PRENATAL	50	33
NUMERO TOMA MUESTRA RAPIDA VIH/SIDA EMBARAZADAS	12	8
COB TOMA MUESTRA RAPIDA VIH/SIDA EMB (SNIS)	40	26
NUMERO TOMA MUESTRA DE PAP EMBARAZADAS	12	2
COB. TOMA MUESTRA DE PAP EMB (SNIS)	12	14
EMBARAZADAS CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO	12	8
COB EMBARAZADAS DOSIS COMPL HIERRO (SNIS)	40	25



ANÁLISIS TÉCNICO:

Problema o Logro: No hay Integralidad por 4to control, Prueba de VIH, PAP, HIERRO, de acuerdo a la Población Asignada y real

Causas. RRHH: No capacitado en atención integral a la mujer

Equipos o Infraestructura: No se cumple con las normas en los establecimientos del área dispersa por no tener ambientes adecuados.

Medicamentos o Insumos: se tiene la tardanza en el retorno de los resultados de PAP, por el cual las usuarias pierden credibilidad.

Comunidad: Población fluctuante.

Promoción: No se esta haciendo seguimiento en la comunidad.

Calidad de la Información: No se registro los datos de PAP en el mes junio

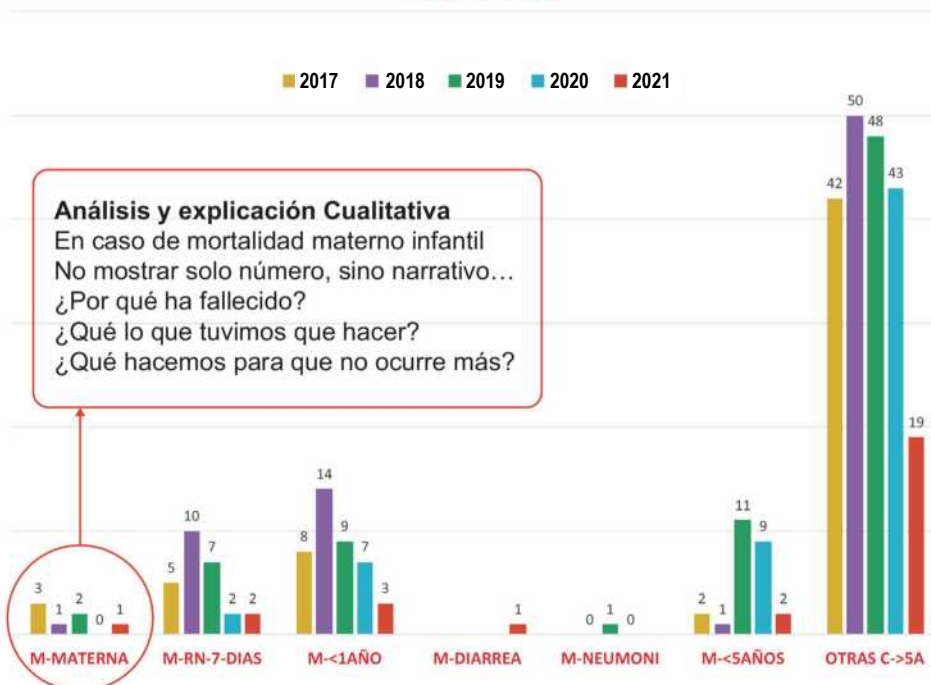
Soluciones a corto Plazo

- Actualización y capacitación en la atención integral de la mujer, al personal nuevo y que reprobaron en la capacitación anterior.
- Puntualizar problemas encontrados en la atención integral de la mujer durante los concejos técnicos
- Gestionar con la GAM para poder implementar el IVAA en los establecimientos.

6 Analizar los riesgos de mortalidad en grupos vulnerables, describir de manera entendible sus causas.

EJEMPLO:

MORTALIDAD



La muerte es un tema muy delicado, por eso, cuando presente información materna infantil relacionada a mortalidad, no solamente muestre números, usted debe profundizar el análisis de los problemas y causas que provocaron la mortalidad, y narrarlas en la exposición.

¿Por qué el fallecimiento? ¿Qué se hizo? ¿Qué haremos ahora para que no ocurran más muertes? ¿Cuándo lo haremos?

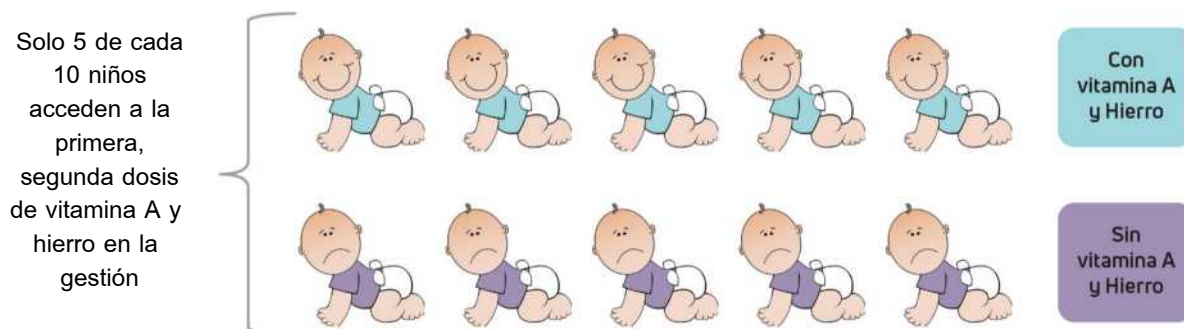
Esta información no solo debe ser analizada por personal estadístico, si no por todo el personal de salud, autoridades y comunidades, caso por caso.

El personal de salud debe discutir y analizar cuál fue la causa de muerte y generar una acción educativa para las comunidades. (Ejemplo: llegaron tarde; el personal de salud no estaba, refirieron muy tarde, y/o la familia no permitió la atención)

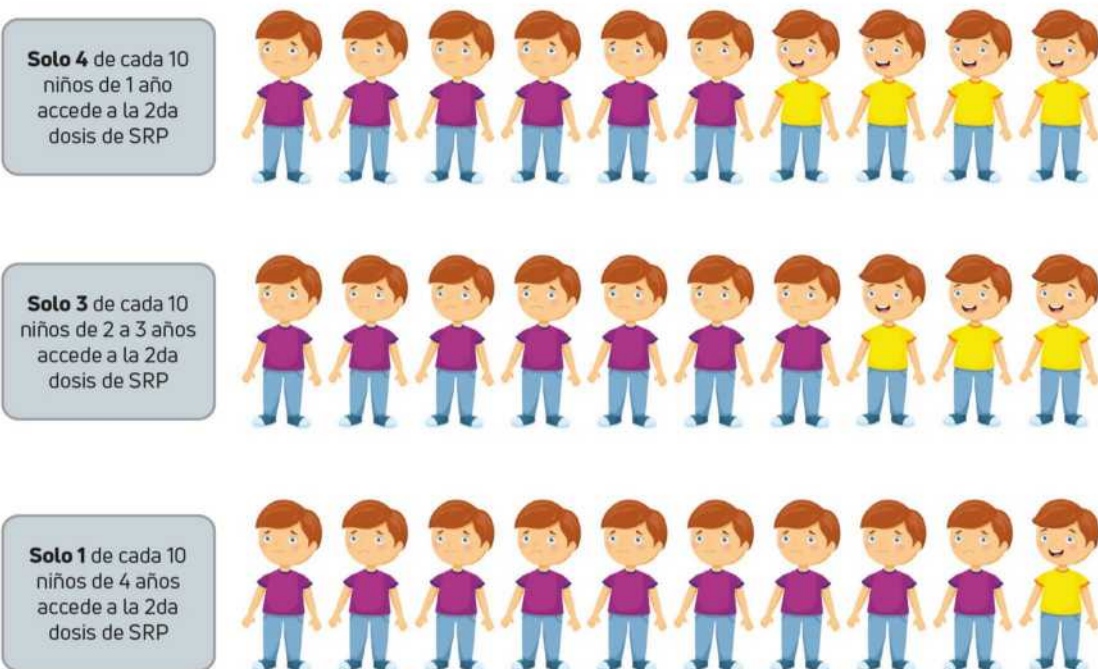
Opciones de presentaciones didácticas, para una mejor comprensión de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal y autoridades de la comunidad o barrio.

EJEMPLOS:

MICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO (enero a septiembre)



COBERTURA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS 1,2,3 y 4 años de la 2da SRP Enero a Septiembre



EMBARAZO ADOLESCENTE MUNICIPIO DE POOPÓ (enero a septiembre)



Embarazadas con 4 controles prenatales Municipio Poopó (enero a septiembre 2021)



El 2020 solo **6 de cada 10** mujeres realizaron 4 controles prenatales



El 2021 **8 de cada 10** mujeres realizaron 4 controles prenatales

No realizar
mínimamente 4
CPN repercute en
riesgos para la
mama y el bebé.



7 Verificar la calidad de información; la presentación de los datos fue realizada sin errores y velando la calidad de la información.

La condición previa para ejecutar un CAI es la calidad de datos sin error y sin demora; por tanto, en su establecimiento, usted debe realizar un monitoreo continuo de la calidad de los datos.

Se recalca que para la realización de un CAI es importante asegurar que los datos sean de calidad, es decir, sin errores y sin demora por ello es importante aplicar los mecanismos de control continuo de calidad.

Pregúntese usted mismo, ¿Si los establecimientos reportan datos con mala calidad... cómo se están tomando las decisiones?

Etapas de Análisis

8 Analizar de los problemas identificados, sus causas y soluciones reflejados en un plan de acción consensuado de forma participativa.

Para comprender esta acción debemos hacernos las siguientes preguntas:

- *¿Cuál es el problema que quiero socializar?*
- *¿Quiénes son los actores estratégicos que pueden ayudarme en la solución del problema?*
- *¿Qué apoyo pretendo lograr para solucionar el problema?*

Un plan de acción puede contener diversas variables, sin embargo, éste debe ser medible y ejecutable por lo que se recomienda utilizar un Instrumento “Matriz de Plan de Acción” (Anexo 3):

PROBLEMA	CAUSA		RESULTADO A LOGRAR
(considere morbilidad, bajas coberturas y no integralidad otros)	(identifique cuales son las causas que estan produciendo el problema)		Describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto)
BAJAS Coberturas area dispersa, y no hay integralidad a la mujer embarazada en control prenatal en algunos en atención de Parto	① Recursos humano en salud, cumplimiento de Normas	① Cambio de Personal.	Llegar al 60% de coberturas de forma integral
	② Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros	① Ausencia de Servicios básicos, para atención del parto. ② Equipamiento para la atención del parto	
	③ Medicamentos o Insumos	① No se tiene pruebas de VIH. ② Para la alimentación en la atención de parto no se tiene personal	
	④ Comunidad (Población)	① Falta de seguimiento a la población real. Poblacion sobre estimada	
	⑤ Promoción de Salud (Actividad Comunitaria y Familiar)	① Las usuarias no aceptan PAP por miedo por amenaza de aborto.	
	⑥ Calidad de información	① Se tiene observaciones con la Calidad del Dato del mes de Enero	

Instructivo de llenado:

Paso 1.- Columna 1 Problema Identificado; de acuerdo a la presentación de indicadores por grupo del continuo de la vida, identifique cuáles son los más críticos.

Paso 2.- Columna Causa. Por cada problema identificado se debe analizar las causas del no cumplimiento se sugieren 6 motivos mencionados en la presentación. Si no existen algunas causas mencionadas no es necesario anotarlas.

Paso 3.- Resultado a lograr: Coloque qué meta se lograría si se resolviera el problema.

Estos 3 pasos deben ser llenados en paralelo a las presentaciones del CAI o prepararlas con anticipación por el sector salud.

Eta de identificación de alternativas de solución y toma de decisiones

9 Tomar de decisiones. En el plan de acción se asigna responsabilidades específicas a las autoridades de la Estructura social, Gobierno Autónomo Municipal y personal de salud.

Análisis			Plan de acción								
PROBLEMA	CAUSA		RESULTADO A LOGRAR	ACCIÓN	Marque una cruz en el ámbito en el que corresponde incluir la actividad (que instancia hará el apoyo)				MEDIOS	FECHAS PROGRAMADAS	RESPONSABLE
(considere morbilidad, bajas coberturas y/o integralidad otros)	(identifique cuáles son las causas que están produciendo el problema)		(describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto))	(anote la actividad que elimine o disminuya la causa que produce el problema)	Comunidad o barrio (Estructura Social)	Establ. de Salud	PIMS	POA	Fuente de Equipamiento para ejecutar la actividad (recursos económicos, materiales, medios audiovisuales etc.)	Anote fecha de inicio, programación, trimestres correspondientes)	(Considere personal de salud, Autoridades de la Comunidad, Autoridades Municipales)
BAJAS Coberturas área dispersa, y no hay integralidad a la mujer embarazada en control prenatal en algunos en atención de Parto	① Recursos humanos en salud, cumplimiento de Normas	① Cambio de Personal.	Llegar al 60% de coberturas de forma integral	① Garantizar los contratos municipales por 1 año.			X	X	① SIS	① Oct 2016.	① GAM y CIMS
	② Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros	① Ausencia de Servicios básicos, para atención del parto. ② Equipamiento para la atención del parto		① Gestionar para la instalación de Servicios Básicos ② Gestionar la compra de equipamiento para la atención del Parto				X	① Cooperación del POA ① SIS Remanentes	①	① GAM y CIMS
	③ Medicamentos o Insumos	① No se tiene pruebas de VIH. ② Para la alimentación en la atención de parto no se tiene personal		① Realizar la adquisición de los insumos para estas dos actividades. Pruebas de VIH y alimentación				X	① SIS	① Sep.2016.	① GAM, R.M.C.S.
	④ Comunidad (Población)	① Falta de seguimiento a la población real. Población sobre estimada		① Hacer seguimiento de las Carpetas familiares.	X	X				① Oct 2016	① R.M.C.S.
	⑤ Promoción de Salud (Actividad Comunitaria y Familiar)	① Las usuarias no aceptan PAP por miedo por amenaza de aborto.		① Realizar orientación a MER, realizar sesiones educativas en el grupo familiar.	X	X				① Oct 2016.	① R.M.C.S. Y CIMS
	⑥ Calidad de información	① Se tiene observaciones con la Calidad del Dato del de Enero		① Hacer un censo identificar la procedencia de las atenciones .		X				① Oct 2016.	① R.M.C.S. ② GAM

Instructivo del llenado

Paso 1 Columna acción: Deben proponerse y consensuar actividades claras y específicas para ser cumplidas.

- ① Técnicas propias del sector salud
- ② Los costos necesarios para resolver problemas incorporados en el POA.
- ③ El POA se elabora en base al Plan Municipal de Salud, por tanto, respeta una línea a cumplir durante los 5 años de programación; sin embargo, el POA puede ser modificado o reformulado mediante concertación en la Mesa Municipal.
- ④ Dar mayor Responsabilidad a la Estructura Social y a través de ellos a la comunidad y al barrio

Paso 2 Columna ámbito: Identificar a cuál de los 3 actores les corresponden actuar: Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal (GAM), Autoridades de la comunidad o barrio, Personal de salud.

Paso 3 Columna medios: Identificar los recursos necesarios para cumplirlos. Si no se necesita recursos no colocar nada.

Paso 4 Cronograma: Colocar la fecha de Inicio consensuada con todos los actores.

Paso 5 Responsable: Colocar el nombre específico del que realizará o liderará las gestiones.

Por lo tanto, el CAI es la instancia para la toma de decisiones a corto plazo, éstas deben relacionarse con la ejecución del POA en base a las necesidades o demandas presentadas. Estas necesidades pueden surgir del CAI y las demandas de la comunidad, entonces nos preguntamos: ¿qué es lo importante de la mesa municipal?; pues es, asegurar el presupuesto con la demanda y necesidad real de la comunidad y del Establecimiento de salud.

Entonces, todo el análisis del CAI, debe ser monitoreado verificando si el presupuesto está asegurado y si se está ejecutando, así como las acciones del sector salud, de la comunidad y del barrio.

- El resultado principal del CAI es el **plan de acción** a partir de los problemas identificados se identifican los problemas, causas y las actividades para resolver el problema, en ese momento, se requiere saber los costos de actividad, por lo menos saber si se requiere dinero, pues hay actividades que no tienen costo económico, como por ejemplo el cambio de comportamiento de la comunidad, tampoco tiene sentido programar actividades que requieran excesivo dinero.

10 Optimizar el tiempo de duración del CAI. (Tiempo de presentación, análisis y elaboración de plan de acción menor a 6 horas)

Las presentaciones deben ser cortas, concisas y claras. Luego de la exposición todos los participantes deben, analizar y discutir los datos presentados para posteriormente realizar el plan de acción (esto deberá tomar entre 1 a 2 horas), puesto que las Autoridades Municipales no cuentan con mucho tiempo.

10.3 FASE DE SEGUIMIENTO

Esta fase es posterior a la reunión y tiene el propósito de monitorear y evaluar las decisiones tomadas en el CAI mediante un seguimiento al plan de acciones. La misma contempla las siguientes tareas:

- Elaboración, revisión y aprobación de actas
- Definición del plan de seguimiento
- Realización de reuniones de control y evaluación del cumplimiento del plan.
- Monitoreo de las acciones definidas (espacio de comentarios)

	FASE DE SEGUIMIENTO	FUENTE VERIFICACIÓN
1	Realizar el seguimiento del "Plan de acción en el GAM (incorporó recursos económicos, mejoró la ejecución de los recursos)	Actas de reuniones o Cartas de solicitudes
2	Realizar el seguimiento del "Plan de acción en la estructura Social en Salud" (mejoro la ejecución de los recursos)	Actas
3	Realizar al menos una reunión de concejo técnico con responsables de su establecimiento para hacer seguimiento al Plan de Acción.	Actas
4	Si no fueron cumplidos los compromisos, identificó las causas (económicas, logística y otras) para buscar otras acciones para cumplirlos.	Actas
5	Se tiene fecha del próximo CAI.	Actas

- ❶ **Seguimiento a los acuerdos del "Plan de acción del GAM"**: Se debe hacer el seguimiento a los compromisos por parte de las autoridades del gobierno municipal, con diferentes métodos de gestión a través de notas, reuniones y otras, se garantizará el cumplimiento del Plan
- ❷ **Seguimiento a los acuerdos del "Plan de acción de la estructura social en Salud"** ; Estas acciones estarán relacionados con las acciones que fueron desarrollados a nivel de población, motivados por las autoridades locales de salud, esto se puede hacer en las reuniones de la comunidad y barrio.
- ❸ **Seguimiento a los acuerdos del "Plan de acción del personal de salud"**: A través de los consejos técnicos que deben ser desarrollados mensualmente.
- ❹ **Nuevos acuerdos de acuerdo al avance**: Seguramente existirán acciones que no fueron desarrollados y aunque se hayan cumplido se debe ver si el problema que se pretendía cumplir ya se resolvió, si no es así las acciones deben hacerlo de forma continua.
- ❺ **Planifica la próxima fecha del CAI**: es importante colocar la fecha para que se pueda identificar el próximo seguimiento del CAI y así las metas colocadas se podrá poner un tiempo.

PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Fecha de CAL: 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2016.

Fecha de seguimiento: Diciembre

Análisis			Plan de acción					Seguimiento			
PROBLEMA	CAUSA	RESULTADO A LOGRAR	ACCION	Marque una cruz en el ámbito en el que corresponde incluir la actividad (que instancia hara el apoyo)	POA	MEDIOS	FECHAS PROGRAMADAS	RESPONSABLE	Ejecutado	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Descripción de los alcances
(considere morbilidad, bajas coberturas y no integralidad otros)	(identifique cuales son las causas que estan produciendo el problema)	Describe el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto)	(anote la actividad que elimine o disminuya la causa que produce el problema)	Comunid. Establ. de Salud Estructur a Social)		Fuente de financiamiento para ejecutar la actividad (recurso economico, materiales, medios audiovisuales etc).	Anote fecha o fechas programadas (trimestre correspondiente a Autoridades Municipales)	(Considere : personal de salud- Autoridades de la Comunidad - Municipales)	25%	75%	100%
BAJAS Coberturas control prenatal	1 Recursos humano en salud, cumplimiento de Normas	1 Cambio de Personal.	1 Garantizar los contratos municipales por 1 año.	x		1 SIS	1 Oct 2016.	1 GAM y CSMS	25%		1 SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE AL PRESUPUESTO
	2 Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros	1 Ausencia de Servicios basicos, para atención del parto.	1 Gestionar para la instalación de Servicios Basicos		x	1 Cooperación del POA	1	1 GAM y CSMS	50%		1 S ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AREA RURAL SE REAFORZARON. 2 C.S. URBANOS NUEVOS Y SE PROGRAMARÁ 3 C.S. PARA 2017. 2 SE REALIZA JUNTO CON LA REAFORC. 3 SE PRIORIZO POR LA IMPORTANCIA EQUIPO PARA ANESTESIOLOGIA PARA EL HOP. E.E.
		2 Equipamiento para la atención del parto	2 Gestionar la compra de equipamiento para la atención del Parto		x	1 SIS Remanentes					
	3 Medicamentos o Insumos	1 No se tiene pruebas de VIH. 2 Para la alimentación en la atención de parto no se tiene personal	1 Realizar la adquisición de los insumos para estas dos actividades. Pruebas de VIH y alimentación		x	1 SIS	1 Sep 2016.	1 GAM . R.M. C.S.	25%		1 NO SE REALIZO LA ADQUISICION 2 ESTÁ REVISANDO PRODUCTOS DE LA LEY 475
	4 Comunidad (Población)	1 Falta de seguimiento a la población real. Poblacion sobre estimada	1 Hacer seguimiento de las Cartelas familiares.	x			1 Oct 2016	1 R.M. C.S.	65%		1 SE ESTA ACTUALIZANDO LAS C.F. 2 SE REALIZO S.E. EN COORDINACIÓN CON LA UC. OBJETIVO 1. 3 SE REALIZO 4 NO SE REALIZO
	5 Promoción de Salud (Actividad Comunitaria y Familiar)	1 Las usuarias no aceptan PAP por miedo por amenaza de aborto.	1 Realizar orientación a MEF. realizar sesiones educativas en el grupo familiar.	x			1 Oct 2016.	1 R.M. C.S. Y CLS	75%		1 SE HIZO SEGUIMIENTO SOBRE TODO EN AREA RURAL 2 SE VA FORTALECIENDO CON LA ASISTENCIA DE ENFERMEROS PARA MAYOR SEGUIMIENTO
	6 Calidad de información	1 Se tiene observaciones con la Calidad del Dato del mes de Enero	1 Hacer un censo identificar la procedencia de las atenciones .	x			1 Oct 2016.	1 R.M C.S. 2 GAM	25%		1 SE CORRIGIO 1 INFORMACION M.E.E. 2 SE DEBE IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS Y PRIORIZAR PARA LA REPARACION

En la fase posterior a la ejecución del CAI, después de haber tomado decisiones es importante realizar el seguimiento al plan de acción, a su ejecución y costo, y asegurarse que este plan se refleje en el POA a través de la mesa de salud.

Esto nos permitirá verificar si la meta ha sido cumplida en el tiempo debido y realizar seguimiento a la implementación del plan de acción en el establecimiento.

En el siguiente CAI el orden de la fase de desarrollo debe contemplar la:

- Presentación de los participantes.
- Explicación de la metodología de trabajo.
- Lectura del acta anterior y presentación de resultados del Plan de acción del anterior CAI.
- Exposición de los resultados.
- Recepción de documentos por parte de los participantes.

La parte azul de la matriz del plan de acción permite ver si se ha cumplido o no

EJEMPLO

PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO



Análisis				Plan de acción			Seguimiento		
PROBLEMA	CAUSA	RESULTADO A LOGRAR	FECHAS PROGRAMADAS	MEDIOS	ACCION	RESPONSABLE	Ejecutado	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Descripción de los alcances
(considere morbilidad, bajas coberturas y/o integralidad otros)	(Identifique cuales son las causas que están produciendo el problema)	Describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto)							
BAJAS Coberturas control prenatal	1 Recursos humano en salud, cumplimiento de normas	1 Cambio de Personal.	1 Oct 2016.	1 SIS	1 Garantizar los contratos municipales por 1 año.	1 GAM y CSMS	25%		1 SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE AL PRESUPUESTO
	2 Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros	1 Ausencia de Servicios básicos, para atención del parto.	1	1 Cooperación del POA	1 Gestionar para la instalación de Servicios Básicos	1 GAM y CSMS	50%		1 5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL AREA RURAL SE REFINANCIARON, 2 C.S. URBANOS NUEVOS Y SE PROGRAMA 3 C.S. PARA ENERO 2 SE REALIZA JUNTO CON LA REFINACCIÓN 3 SE PRIORIZO POR LA IMPORTANCIA EQUIPO PARA ANESTESIOLOGIA PARA EL HOSP. E.E.
		2 Equipamiento para la atención del parto		1 SIS Remanentes	2 Gestionar la compra de equipamiento para la atención del Parto				
	3 Medicamentos o Insumos	1 No se tiene pruebas de VIH. 2 Para la alimentación en la atención de parto no se tiene personal	1 Sep. 2016.	1 SIS	1 Realizar la adquisición de los insumos para estrados actividades. Pruebas de VIH y alimentación	1 GAM, R.M. C.S.	25%		1 NO SE REALIZO LA ADQUISICION 2 ESTA REVISANDO PAQUETES DE LA LEY 475
	4 Comunidad (Población)	1 Falta de seguimiento a la población real. Población sobre estimada	1 Oct 2016		1 Hacer seguimiento de las Cerpías familiares.	1 R.M. C.S.	65%		1 SE ESTA ACTUALIZANDO LAS CP. 2 SE REALIZO S.E. EN COORDINACIÓN CON LA LIC. DISTRICTAL 3 EN PROCESO 4 NO SE REALIZO
	5 Promoción de Salud (Actividad Comunitaria y Familiar)	1 Las usuarias no aceptan PAP por miedo por amenaza de aborto.	1 Oct 2016.		1 Realizar orientación a MEF, realizar sesiones educativas en el grupo familiar.	1 R.M. C.S. Y CLS	75%		1 SE HIZO SEGUIMIENTO SOBRE TODO EN AREA RURAL 2 SE VA FORTALECIENDO CON LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLOS PARA MAYOR SEGUIMIENTO
	6 Calidad de información	1 Se tiene observaciones con la Calidad del Dato del mes de Enero	1 Oct 2016.		1 Hacer un censo identificar la procedencia de las atenciones.	1 R.M. C.S. 2 GAM	25%		1 SE CORRIGIO L INFORMACION H.E.E. 2 SE DEBE IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS Y PRIORIZAR PARA LA REPARACIÓN

La presentación de los resultados del Plan de Acción del anterior CAI permite evaluar las acciones programadas y analizar las causas que impidieron el cumplimiento de las mismas en caso que no se hayan cumplido.

11. EVALUACIÓN DEL CAI

Una herramienta para realizar el control, es la matriz de cumplimiento de las fases, ésta consiste en utilizar una **Lista de acciones del CAI**, que, revisadas en forma conjunta, al finalizar el CAI, mostrará los parámetros de Calidad, lo que ayudará a mejorar los siguientes eventos y el cumplimiento al Plan de acción.

La Lista de acciones (revisión de pasos) debe ser utilizada en cada fase para verificar lo que se debe cumplir. También se ha realizado para cada nivel ya que los actores y algunos puntos cambian (**Ver: el Anexo del 3 al 5, los establecimiento de salud de primer nivel, segundo nivel y municipio**).

USO DE LISTA DE ACCIONES PARA 3 FASES			
Nº	FASE DE SEGUIMIENTO	SI	NO
1	El seguimiento al cumplimiento a los compromisos lo realiza el responsable municipal de la red		
2	Se realiza el seguimiento al cumplimiento de actividades propuestas en el plan de acción del anterior CAI		
3	Si no son cumplidos los compromisos se replantean acciones para cumplirlos		
4	Durante el CAI se percibe el liderazgo del responsable municipal .		
5	Se fija fecha del próximo CAI (Colocar la fecha:.....)		
6	Se realiza la fase de seguimiento de acuerdo a lo mencionado. (Con solo el incumplimiento de un ítem de la fase de preparación califica como NO)		
TOTALES (el 100% es 33)			



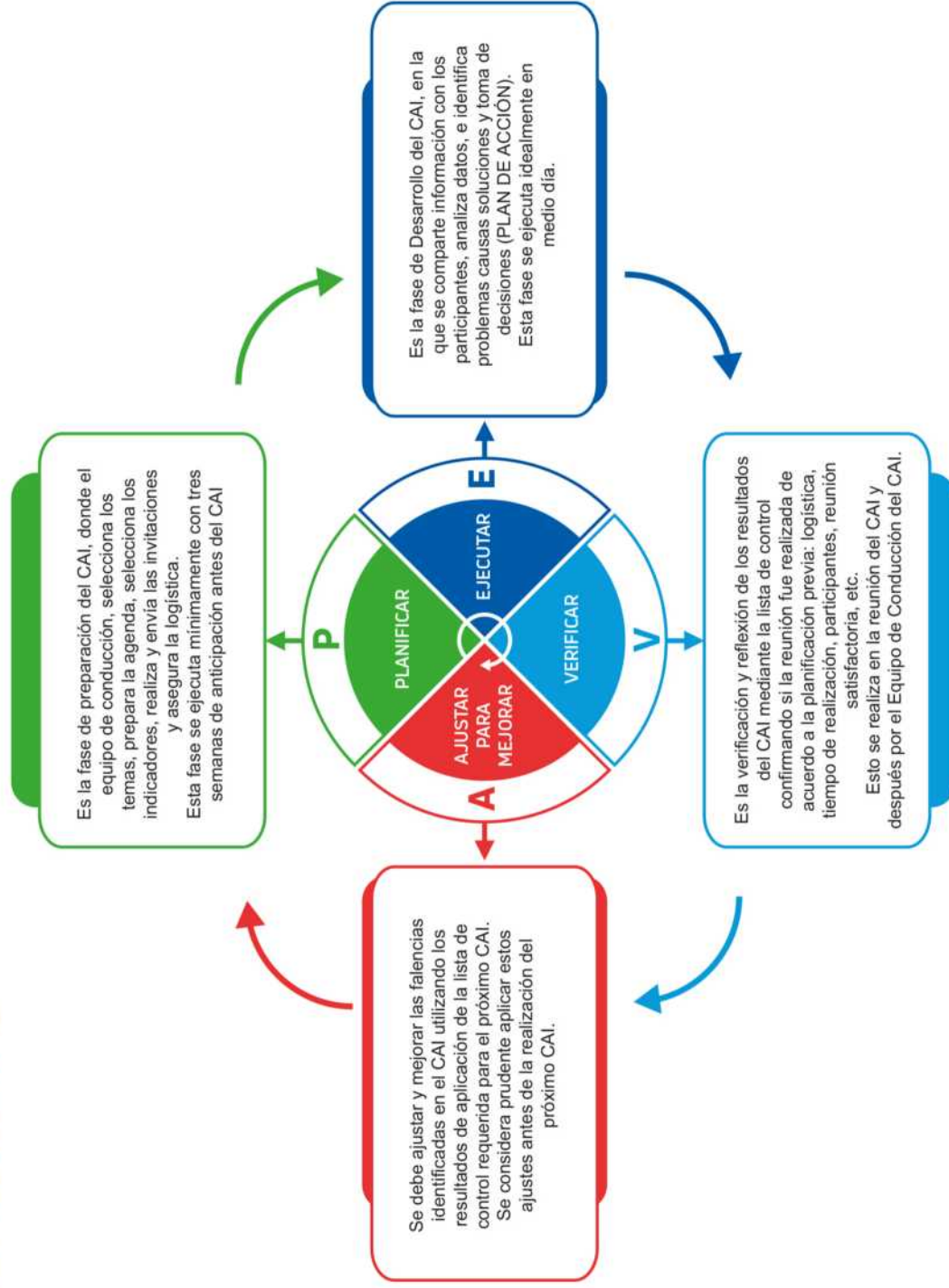
Carpeta del CAI: Un modo de Organizar de forma continua la realización CAI, es contar con una Carpeta o Archivador donde se verifique toda la lista de acciones del Instrumento “Lista de Acciones del CAI”



Al emitir el boletín informativo, se puede difundir los resultados del CAI a las personas que no asistieron al CAI.

Otro aspecto importante es la difusión de los resultados del CAI, a través de los boletines informativos (ejemplo: Coordinación de red Tupiza), para que se conozca la información en la comunidad y en el personal de salud.

11.1 RESUMEN DEL CICLO PARA MEJORAR EL MANEJO DEL CAI, UTILIZANDO LOS RESULTADOS DE LA LISTA DE CONTROL.



11.2 BENEFICIOS DE FORTALECER EL CAI

El CAI no debe ser solo una obligación, su aplicación es muy beneficiosa para la toma de decisiones correctas, priorizadas y adecuadas en salud.

- Se puede socializar la problemática de salud local y permite visualizar metas claras para mejorar el estado de salud.
- Garantizar y permitir el seguimiento de ejecución presupuestaria para la salud.
- Es un espacio en el que se puede tomar decisiones en base a la necesidad de la comunidad.
- Permite empoderar a la comunidad.
- El Personal de Salud respeta las opiniones de la comunidad.
- El CAI es una herramienta para profundizar la coordinación entre el personal de salud, autoridades municipales y comunitarias.

12. EPÍLOGO

Se ha elaborado esta Guía con el fin de facilitar la realización del CAI esperando disminuir las barreras que el personal de salud ha venido presentando en su desarrollo, a través de la aplicación de metodologías exitosas para la toma de decisiones.

Con la realización de CAI, se logran muchos beneficios como se menciona arriba. En este sentido, se debe realizar el CAI de acuerdo a norma periódica, para que pueda reflejar las opiniones recolectadas con las comunidades para la elaboración de POA.

Lo más importante es que con esta herramienta, la responsabilidad no se delega a una sola persona, sino que involucra a todos los actores que deben ser partícipes del CAI. Es decir, no solo el personal de salud, (responsable de estadística, responsable de salud del Gobierno Municipal y equipo de coordinación de Red de Salud), sino convocando a autoridades de las comunidades, responsable del consejo municipal y hasta el Alcalde para que sean partícipes activos desde la etapa de preparación.

Esperamos que esta Guía le sea de utilidad; ¡lo importante es intentar cambiar!

13. BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Salud -SNIS-VE, Abruzzese Rocco. Guía de aplicación del Comité de análisis de información (CAI). La Paz-Bolivia: SNIS -VE Ministerio de Salud, DTN-321; 2014.
2. Ministerio de Salud y Deportes -SNIS-VE. Guía de aplicación del Comité de análisis de información (CAI). La Paz-Bolivia: SNIS -VE Ministerio de Salud y Deportes. 2008.
3. Carro Paz & Gonzáles Gómez. Administración de la Calidad Total. 2012.
4. Ministerio de Salud y Deportes. Salud Familiar Comunitaria Intercultural. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes, DTN-304; 2013.
5. Servicio Departamental de Salud Potosí- SNIS-VE, Proyecto FORSA-Potosí/JICA. Guía de CAI simplificado para todos. Primera edición. Potosí-Bolivia: SEDES Potosí; 2015.
6. Servicio Departamental de Salud Oruro- SNIS-VE, Proyecto FORSA-Oruro/JICA. Guía Simplificada del Comité de análisis de información, CAI para todos. Primera edición. Oruro-Bolivia: SEDES Oruro; 2019.
7. Ministerio de Salud y Deportes. Guía de mejoramiento continuo de la Información. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes, 2008.
8. Ministerio de Salud y Deportes. Guía general de indicadores en gestión en salud. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes, 2008.
9. Ministerio de Salud y Deportes. Normas nacionales de atención clínica, NAC. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes, DTN-288; 2013.
10. Ministerio de Salud y Deportes. Normas nacionales de caracterización de establecimientos de salud de primer nivel. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes-DGSS, DTN-288; 2013.
11. Ministerio de Salud. Guía de procedimientos de la gestión participativa local en salud. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud-DGPS, DTN-381; 2015.
12. Ministerio de Salud y Deportes. Guía local de educación para la vida. La Paz-Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes-DGPS, DTN-322; 2013.
13. Ministerio de Salud SNIS-VE, [Internet]. La Paz – Bolivia 2020 [Guías, actualizada año 2020]. Disponible en: <https://snis.minsalud.gob.bo/publicaciones/category/18-guias>

14. ANEXOS

CD Interactivo: Anexo 1 Instrumento de selección indicadores de Establecimientos de Primer nivel y municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA EL CAI Instructivo de Llenado

MENU

REGISTRO DE DATOS

- Menores a 2 años
- Niños de 2 a 5 años
- Niños de 5 a 9 años
- Adolescentes de 10 a 19 años
- Mujeres
- Poblacion General
- Mayores a 60 años

RESULTADOS

- Menores a 2 años
- Niños de 2 a 5 años
- Niños de 5 a 9 años
- Adolescentes de 10 a 19 años
- Mujeres
- Poblacion General
- Mayores a 60 años

CD Interactivo: Anexo 2 Instrumento de selección de indicadores Hospitalarios – Segundo. nivel

MENU REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL HOSPITALARIA

Aplicativo hospitalario CAI.

REGISTROS

- Información General del Hospital
- Servicio de Gineco Obstetricia
- Servicio de Pediatría
- Servicio de Medicina Interna
- Servicio de Cirugía
- Otros Servicio Hospital

RESULTADOS

- Información General del Hospital
- Servicio de Gineco Obstetricia
- Servicio de Pediatría
- Servicio de Medicina Interna
- Servicio de Cirugía
- Otros Servicio Hospital

Anexo 3 Matriz “LISTA DE ACCIONES” Formulario de evaluación del CAI para Establecimientos de Primer Nivel de Atención.

	FASE DE PREPARACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Conformar un equipo de conducción del CAI Establecimiento de Salud	Acta de reunión
2	Realizar el CAI según la periodicidad establecida según el nivel Establecimiento de salud.	Verificar fecha según la frecuencia establecida
3	Preparar y seleccionar los indicadores de análisis de acuerdo a la necesidad y priorización, relacionados con el Plan Municipal, PTDI u otros, ordenados por el ciclo del continuo de la vida (Atención, Prevención, Promoción, Referencia, Gestión u otros).	Matriz de Selección de Variables. (Digital)
4	Contar con información del presupuesto de salud, programación y ejecución a la fecha de realización del CAI	Reportes de ejecución
5	Preparar las presentaciones incorporando el análisis técnico de los indicadores no cumplidos y las causas identificadas	Presentación PowerPoint.
6	Asegurar la participación de: - Estructura Social en Salud(Consejo Social Municipal, Comité Local de salud, Autoridades Locales de Salud) - Instituciones Educación, SLIM, Universidad, deporte, otras Envío las convocatorias e invitación con anticipación. Se envió la convocatoria al Personal de Salud con anticipación	Cartas de convocatoria y confirmación
7	Enviar con anticipación la agenda del evento y los temas e indicadores a ser presentados y analizados.	Agenda enviada
8	Preparar la logística anticipadamente. (Salón, ecran, equipo multimedia, suficientes sillas, iluminación y otros)	Observación del lugar el inicio.

	FASE DE DESARROLLO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Confirmar la asistencia y realizó la presentación de los participantes: a) Presidente del Concejo Social Municipal, Representantes del Comités Locales de Salud y/o representantes de la Comunidad. b) Personal de salud de los Establecimientos de Salud convocados.	Acta
2	Verificar la participación de otros sectores o instituciones como Educación, Medio Ambiente, Producción, Defensorías, Cooperantes u otros.	Acta
3	Realizar la explicación de la agenda, y la metodología de trabajo a seguir durante el CAI.	Presentaciones
4	Realizar la lectura de compromisos y el seguimiento al plan de acción anterior con los compromisos de todos los actores	Acta
5	Presentar y analizar los indicadores priorizados. Idealmente por grupos del ciclo Vital (Atención, Prevención, Promoción, Rehabilitación, Referencia Gestión u otros), identificando problemas y sus causas o el logro y sus fortalezas con gráficos fáciles de entender	Presentaciones
6	Analizar de riesgos de mortalidad en grupos vulnerables, se describió de manera entendible sus causas.	Presentaciones
7	Verificar la calidad de información en la presentación de los datos, ésta fue realizada sin errores y coherente al SNIS.	Presentaciones
8	Analizar de los problemas identificados, sus causas y las soluciones reflejadas en un plan de acción consensuado de forma participativa.	Instrumento de plan de acción.
9	Tomar decisiones. En el plan de acción se asignó responsabilidades específicas a las autoridades, Estructura Social, Gobierno Municipal y Personal de Salud. Se realizó el Acta del CAI con sus firmas	Acta y Plan de Acción
10	Optimizar el tiempo de duración del CAI. (Tiempo de presentación, análisis y elaboración de plan de acción menor a 6 horas)	Confirmar

	FASE DE SEGUIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el seguimiento del Plan de acción (se incorporó las mejoras a la ejecución de los recursos del GAM)	Actas de reuniones o Cartas de solicitudes
2	Realizar el seguimiento del Plan de acción en la estructura Social (gestión y mejora en la ejecución de los recursos)	Actas
3	Realizar al menos una reunión con responsables de su establecimiento para hacer seguimiento al Plan de Acción.	Actas
4	Si no fueron cumplidos los compromisos, identificó las causas (económicos, logística y otros), para buscar otras acciones a ser efectuadas.	Actas
5	Se tiene fecha del próximo CAI.	Actas

Anexo 4 Matriz “LISTA DE ACCIONES” Formulario de evaluación del CAI para Establecimientos de Segundo Nivel Atención.

	FASE DE PREPARACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Conformar un equipo de conducción del Hospital de 2do nivel (El equipo de conducción es el que dirige el CAI).	Acta de reunión
2	Realizar el CAI según la periodicidad establecida según el nivel Establecimiento de salud.	Verificar fecha según la frecuencia Establecida
3	Preparar y seleccionar los indicadores Hospitalarios de análisis, de acuerdo a necesidad y priorización, relacionados con el Plan municipal, PTDI u otros, por especialidades básicas.	Matriz de Selección de Variables. (Digital)
4	Contar con información del presupuesto de salud, programación y ejecución en la fecha de realización del CAI	Reportes de ejecución
5	Preparar las presentaciones incorporando el análisis técnico de los indicadores no cumplidos y las causas identificadas	Presentación PowerPoint.
6	Asegurar la participación de: - Representante del Gobierno Autónomo Municipal. - Estructura Social en Salud (Consejo Social Municipal, Comité Local de salud, Autoridades Locales en Salud) - Instituciones del Municipio (Educación, SLIM, Universidad, deporte) otras Enviando las convocatorias e invitación con anticipación. Se envió la convocatoria al Personal de Salud con anticipación	Cartas de convocatoria y confirmación
7	Enviar con anticipación la agenda del evento y los temas e indicadores a ser presentados y analizados.	Agenda enviada
8	Preparar la logística anticipadamente. (Salón, ecran, equipo multimedia, suficientes sillas, iluminación y otros)	Observación del lugar el inicio.

	FASE DE DESARROLLO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Confirmar la asistencia y realizó la presentación de los participantes: a) Autoridades del Gobierno Municipal (Alcalde, o Miembros del Consejo Municipal u Oficial de Desarrollo Humano, Financiero, o Responsable de Salud del Consejo) b) Presidente del Consejo Social Municipal, Representantes del Comités Locales de Salud y/o representantes de la Comunidad. c) Personal de salud del hospital convocado. d) Otros representantes de instituciones.	Acta
2	Participación de otros sectores o instituciones como Educación, Medio Ambiente, Producción, Defensorías, Cooperantes u otros.	Acta
3	Realizar la explicación de la agenda y de la metodología de trabajo a seguir durante el CAI.	Presentaciones
4	Realizar la lectura de compromisos y el seguimiento al plan de acción anterior con los compromisos de todos los actores	Acta
5	Presentar y realizar el análisis técnico de los indicadores priorizados. Por grupos del ciclo Vital (Atención, Prevención, Promoción, Rehabilitación, Referencia Gestión u otros), identificando problemas, sus causas o el logro y sus fortalezas con gráficos fáciles de entender.	Presentaciones
6	Análisis de los riesgos de mortalidad en grupos vulnerables. Las causas fueron descritas de manera entendible.	Presentaciones
7	La presentación de los datos fue realizada sin errores y coherente al SNIS - VE. Calidad de información.	Presentaciones
8	Análisis de los problemas identificados sus causas. Las soluciones fueron reflejadas en un plan de acción consensuado de forma participativa.	Instrumento de plan de acción.
9	Tomar decisiones. Se asignó responsabilidades específicas a las autoridades, en el plan de acción A) Estructura Social en Salud, B) Gobierno Municipal y C) Personal de Salud. Y se realizó el Acta del CAI con sus firmas	Acta y Plan de Acción
10	Se optimizó el tiempo de duración del CAI. (Tiempo de presentación, análisis y elaboración de plan de acción menor a 6 horas)	Confirmar

	FASE DE SEGUIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el seguimiento del Plan de acción en el GAM (incorporó recursos económicos, mejoró la ejecución de los recursos).	Actas de reuniones o Cartas de solicitudes
2	Realizar el seguimiento del Plan de acción en la estructura Social (gestión y mejora en la ejecución de los recursos).	Actas
3	Realizar al menos una reunión de consejo técnico con responsables de su establecimiento para hacer seguimiento al Plan de Acción.	Actas
4	Si no fueron cumplidos los compromisos, identificó las causas (económicos, logística y otros) para buscar otras acciones para cumplirlos.	Actas
5	Se tiene fecha del próximo CAI.	Actas

Anexo 5 Matriz “LISTA DE ACCIONES” Formulario de evaluación del CAI para Municipio

	FASE DE PREPARACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Conformar un equipo de conducción del CAI Municipal (El equipo de conducción es el que dirige el CAI).	Acta de reunión
2	Realzar el CAI según la periodicidad establecida según el nivel Municipal	Verificar fecha según la frecuencia Establecida
3	Preparar y seleccionar los indicadores de análisis de acuerdo a necesidad y priorización, relacionados con el Plan Municipal, PTDI u otros, por el ciclo Vital (Atención, Prevención, Promoción, Referencia, Gestión u otros).	Matriz de Selección de Variables. (Digital)
4	Contar con información del presupuesto de salud programación y ejecución a la fecha de realización del CAI	Reportes de ejecución
5	Preparar las presentaciones incorporando el análisis técnico de los indicadores no cumplidos y las causas identificadas	Presentación PowerPoint.
6	Enviar las convocatorias e invitación con anticipación, aseguró la participación de: • Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal. • Estructura Social (Consejo Social Municipal en Salud, Comité Local de salud) • Instituciones del Municipio (Educación, SLIM, Universidad, deporte) otras. Se envió la convocatoria al Personal de Salud con Anticipación	Cartas de convocatoria y confirmación
7	Enviar con anticipación la agenda del evento y los temas e indicadores a ser presentados y analizados.	Agenda enviada
8	Preparar la logística anticipadamente. (Salón, ecran, equipo multimedia, suficientes sillas, iluminación y otros)	Observación del lugar el inicio.

	FASE DE DESARROLLO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Confirmar la asistencia y realizó la presentación de los participantes: a) Autoridades del Gobierno Municipal en el CAI municipal (Alcalde, o Miembros del Consejo Municipal, u Oficial de Desarrollo Humano, Financiero o Responsable de Salud del Consejo) b) Presidente del Consejo Social Municipal en Salud, Representantes del Comités Locales de Salud y/o representantes de la Comunidad. c) Personal de salud de los Establecimientos de Salud convocados.	Acta
2	Verificar si participaron otros sectores o instituciones como Educación, Medio Ambiente, Producción, Defensorías, Cooperantes u otros.	Acta
3	Realizar la explicación de la agenda y metodología de trabajo a seguir durante el CAI.	Presentaciones
4	Realizar la lectura de compromisos y el seguimiento al plan de acción anterior con los compromisos de todos los actores	Acta
5	Presentar y analizar los indicadores priorizados. Idealmente por grupos del ciclo Vital (Atención, Prevención, Promoción, Rehabilitación, Referencia Gestión u otros), identificando problemas y sus causas, o el logro y sus fortalezas con gráficos fáciles de entender	Presentaciones
6	Analizar de riesgos de mortalidad en grupos vulnerables, describió de manera entendible sus causas.	Presentaciones
7	Verificar la calidad de información en la presentación de los datos fue realizada sin errores y coherente a los reportados por el SNIS-VE.	Presentaciones
8	Analiza de los problemas identificados, sus causas y soluciones reflejados en un plan de acción consensuado de forma participativa.	Instrumento de plan de acción.
9	Tomar decisiones. Se asignó responsabilidades específicas a las autoridades de la Estructura Social en Salud, Gobierno Municipal y Personal de Salud en el plan de acción. Se realizó el Acta del CAI con sus firmas	Acta y Plan de Acción
10	Optimizar el tiempo de duración del CAI. (Tiempo de presentación, análisis y elaboración de plan de acción menor a 6 horas)	Confirmar

	FASE DE SEGUIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el seguimiento del Plan de acción en el GAM, incorporó recursos económicos, mejoró la ejecución de los recursos	Actas de reuniones o Cartas de solicitudes
2	Realizar el seguimiento del Plan de acción en la Estructura Social en Salud(gestión y mejora en la ejecución de los recursos)	Actas
3	Realizar al menos una reunión de consejo técnico con responsables de su establecimiento para hacer seguimiento al Plan de Acción.	Actas
4	Si no fueron cumplidos los compromisos, identificó las causas (económicos, logística y otros) para buscar otras acciones para cumplirlos.	Actas
5	Se tiene fecha del próximo CAI.	Actas

Anexo 6 Plan de acción y grado de cumplimiento (Anexo digital) Primer nivel y Municipal

Establecimiento de salud Responsable			PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO									
Análisis			Coordinación de red									
			Municipio		Plan de acción							
Fecha de CAI:			Fecha de seguimiento:									
PROBLEMA	CAUSA	RESULTADO A LOGRAR	ACCIÓN	Marque una cruz en el ámbito en el que corresponde incluir la actividad (que instancia hará el apoyo)	PMIS	POA	MEDIOS	FECHAS PROGRAMADA	RESPONSABLE	Ejecutado	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Descripción de los alcances
(considere morbilidad, bajas coberturas y no integralidad otros)	(identifique cuales son las causas que están produciendo el problema)	Describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto)	(anote la actividad que elimine o disminuya la causa que produce el problema)	Comunidad o barrio (Estructura Social)	Establ. de Salud	POA	Fuente de financiamiento para ejecutar la actividad (recurso económico, materiales, medios audiovisuales etc).	Anote fecha o fechas programadas (trimestre correspondiente)	(Considere : personal de salud- Autoridades de la Comunidad - Autoridades Municipales)		25% 50% 75% 100%	
	➊ Recursos humano en salud, cumplimiento de Normas											
	➋ Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros											
	➌ Medicamentos o Insumos											
	➍ Comunidad (Población)											
	➎ Promoción de Salud (Actividad Comunitaria y Familiar)											
	➏ Calidad de información											

Anexo 7 Plan de acción y grado de cumplimiento CAI Hospitalario (Anexo digital)

PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO CAI HOSPITALARIO

[illegible]

ANEXO EDITORIAL

APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN.

Dr. Motoyuki Yuasa –Asesor principal del proyecto FORSA Oruro -UNIVERSIDAD DE JUNTENDO (Tokio, Japón)
 Dr. Yoshihisa Shirayama - Asesor del proyecto FORSA Oruro UNIVERSIDAD DE JUNTENDO (Tokio, Japón)
 Dr. Vladimir Ticona Calderón- Consultor técnico del Proyecto Fortalecimiento de Redes de Salud Materno Infantil FORSA Oruro.
 Lic. Luis Fernando Revilla- Consultor Técnico del Proyecto Fortalecimiento de Redes de Salud Materno Infantil FORSA Oruro.
 Lic. Midori Endo Cooperante Voluntaria de JICA en Bolivia.

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

Dr. Jhonny Cueto (SEDES - PANDO)
 Dr. Jhonny Velarde (SEDES - PANDO)
 Dr. Boris Claure (SEDES -BENI)
 Dr. Antonio Castro (SEDES -BENI)
 Dr. Edgar Salinas (SEDES –SANTA CRUZ)
 Ing. Ronald Condori (SEDES –SANTA CRUZ)
 Lic. Nadir López (SEDES - POTOSI)
 Dr. Ángel Núñez (SEDES - POTOSI)
 Dr. David Choque (SEDES – ORURO)
 Dra. Martha Bejar (SEDES – ORURO)
 Lic. Martín Largo (SEDES – LA PAZ)
 Dra. Wendy Ramírez (SEDES – LA PAZ)
 Dra. Marcia Ferrel (SEDES – COCHABAMBA)
 Téc. María Esther Rojas (SEDES – COCHABAMBA)
 Dr. Rómulo Huanuco (SEDES – CHUQUISACA)
 Dr. Edgar Yucra (SEDES – CHUQUISACA)
 Dr. Oscar Soruco (SEDES – TARIJA)
 Lic. Franz Jurado (SEDES – TARIJA)
 Lic. Fredy Escobar (UPSMS – MINISTERIO DE SALUD)
 Dr. César Ayala (DGP – MINISTERIO DE SALUD)
 Dr. Elías Huanca (DGP – MINISTERIO DE SALUD)
 Dra. Mariela Becerra (DGSS - MINISTERIO DE SALUD)

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)

Lic. Manabu Ohara –Director residente de JICA Bolivia
 Lic. Shintaro Akiyama – Sub Director de JICA Bolivia
 Dra. Ayumi Tanaka –Responsable de salud de JICA Bolivia
 Lic. Karen Hagiwara –Coordinadora del Proyecto FORSA Oruro
 Dr. Cesar Miranda A –Oficial de Proyectos de JICA Bolivia
 Lic. Anibal Yerko Copa Rocabado – Consultor de JICA Bolivia

ESTAMOS SALIENDO
Adelante

